

revistaacofarma

Farmacia solidaria: compromiso profesional y acción social



PROTAGONISTA

Iria Gabarra Pérez.
Farmacéutica con experiencia
en cooperación internacional

ARTÍCULO

Las vitaminas B1, B6 y B12
en la práctica diaria

ARTÍCULO

Tapones de cerumen: cómo
cuidar los oídos para evitarlos

Bebés a partir de 3 meses*,
niños y adultos

Alto porcentaje de
ingredientes de origen natural

Perfumes sin alérgenos



24h
Hidratación
intensa

Sin jabón

24h
Hidratación
intensa

Hidrata, repara y alivia la irritación de la piel atópica

www.acofarma.com

*validado bajo control pediátrico y dermatológico

Esta es una publicación de periodicidad trimestral,
de difusión gratuita y de propiedad de Acofarma
SCL, entidad aglutinadora de las siguientes
cooperativas farmacéuticas:

APOTECARIS, BIDAFAARMA, COFANO, COFARCA,
COFARCU, COFARLE, COFARME, COFARTE,
COFAS, DFG, FEDEFARMA, HEFAME, NAFARCO,
NOALTIA Y RIOFARCO.

Consejo de redacción: Xavier Casas
Sánchez, Joaquín Luño Beese, Matilde
Sánchez Reyes, Juan Luis Sagaseta
de Ilurdoz Uranga, Santiago Maíz Cal
y Francesc Balletbó Fons.

Redacción: Elena Ameijides
redaccion@revistaacofarma.com
Poeta Joan Maragall 56, 2ºE - 28020 Madrid
Tel 914 353 882 - Fax 914 317 133

Publicidad:
Domingo López (Madrid)
publicidad.madrid@revistaacofarma.com
Tel 636 594 931
Sandra Cunill (Barcelona)
publicidad.barcelona@revistaacofarma.com
Tel 676 448 557

Impresión: Jiménez Godoy, SA

Difusión: 17.505 ejemplares

Depósito legal: M 3842 - 1962

SVR 4575 (26.01.79)

ISSN 0567-7114



Descubre más contenidos en la web:
revistaacofarma.com

La responsabilidad de las opiniones y/o informacio-
nes contenidas en los artículos firmados corresponde
exclusivamente a sus autores. Su publicación no sig-
nifica que Acofarma las avale.

Sumario

Invierno 2025

- 03. Editorial**
- 04. Foco en la cooperativa**
- 12. Actualidad científica**
- 14. Protagonista**
Iria Gabarra Pérez. Farmacéutica con
experiencia en cooperación internacional
- 18. Artículo**
Las vitaminas B1, B6 y B12
en la práctica diaria
- 24. Tu laboratorio de confianza**
- 30. Artículo**
Tapones de cerumen:
cómo cuidar los oídos para evitarlos
- 36. Artículo**
Desde la trinchera del mostrador:
persigue tu sueño
- 44. Planeta salud pública**
Farmacia solidaria: compromiso profesional
y acción social
- 49. Desde el mostrador**

¿Piel seca o deshidratada?

Hidrátala según sus necesidades

Cuidado diario para todo tipo de pieles,
sensibles, secas o muy secas



www.acofarma.com

EDITORIAL

La farmacia está inmersa en un proceso de transformación que amplía su rol más allá de la atención sanitaria. El farmacéutico interviene cada vez con mayor frecuencia en proyectos relacionados con salud comunitaria, educación sanitaria y acciones sociales y medioambientales, consolidándose como un agente social que trasciende la dispensación y el seguimiento terapéutico.

El **III Barómetro Social de la Profesión Farmacéutica**, publicado en septiembre, ofrece una radiografía exhaustiva sobre la contribución de la profesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que lo demuestra: el 60% de los proyectos activos se han puesto en marcha en 2024.

Aunque el 46% de las iniciativas pertenecen al ámbito de la Salud Comunitaria, otro dato revelador del barómetro es que el 95% de los proyectos farmacéuticos analizados están contruidos en alianza con terceros, principalmente instituciones públicas y entidades del Tercer Sector. Plataformas como FarmaColabora, las convocatorias de cooperación internacional del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, o los programas llevados a cabo por los distintos Colegios Oficiales y otros agentes del sector, como las cooperativas farmacéuticas, se suman al impulso de entidades como Farmamundi, Banco Farmacéutico, Farmasolidaria o Fundación El Alto. Todos ellos, en conjunto, están redefiniendo la manera en que el farmacéutico se relaciona con las necesidades actuales de la sociedad, evolucionando de forma coherente con sus demandas.

En este contexto, entrevistamos en este número a Iria Gabarra, farmacéutica y experta en cooperación internacional que está colaborando en el último proyecto de la **Fundación LASEMI Cooperación**.

Su trabajo se centra, junto a un equipo de farmacéuticos y colaboradores de la entidad, en la instalación de un laboratorio de formulación magistral y la capacitación del personal local en el Hospital Saint Jean de Dieu de Afagnan, en Togo, que está transformando por completo la gestión diaria del centro. Allí, la elaboración de jarabes pediátricos, cremas dermatológicas o soluciones anti-sépticas está mejorando la calidad de vida de miles de personas de la región que acuden al centro, mostrando el impacto real, tangible y directo de estas iniciativas.

En el marco de este proyecto, **Acofarma** ha contribuido de manera significativa mediante la donación de materias primas para la elaboración de las fórmulas magistrales, siguiendo la línea de colaboración que hemos mantenido en anteriores ocasiones en iniciativas desarrolladas por la fundación, y que también han generado un impacto social tangible.

Para cerrar este número, además de analizar la evolución social de la farmacia, incluimos otros contenidos que combinan información de actualidad, lanzamientos y artículos farmacéuticos. Entre estos últimos, hablaremos del cuidado de los oídos y la formación de tapones de cerumen, cómo tratar los problema de conciliación del sueño desde la farmacia y analizaremos el papel de las vitaminas B1, B6 y B12 en el día a día.

Grup Fedefarma amplía su almacén de Palau-Solità i Plegamans con una inversión de 28,2 M€

Grup Fedefarma amplía su centro logístico en Palau-solità i Plegamans (Barcelona), reforzando así su servicio en distribución farmacéutica. Con una inversión total de 28,2 M€, la nueva nave cuenta con la máxima robotización e integración con la ya existente, hecho que favorecerá la eficiencia en la preparación de pedidos y permitirá aumentar las rutas simultáneas hacia las farmacias socias.



La ampliación consta de 10.480 m² de almacén y 1.398 m² de oficinas que se suman al centro ya existente, alcanzando una superficie total de más de 28.000 m² que permitirán seguir mejorando la capacidad operativa y de almacenaje, así como potenciar la actividad de operador logístico para terceros. La actuación incluye también nuevos espacios de aparcamiento, zonas verdes e infraestructuras adaptadas a las necesidades logísticas y estratégicas actuales y futuras del grupo. Se prevé que la nueva nave esté en pleno funcionamiento a lo largo del último trimestre de 2026.

COMPROMISO CON LA SALUD Y LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Con esta actuación, el centro logístico cuenta con un control y monitorización térmico que garantiza las condiciones de almacenaje necesarias para la distribución (2-8 °C – 15-25 °C); con las zonas operativas requeridas y debidamente identificadas como la recepción, el almacenaje, la preparación de pedidos o la zona de devoluciones, entre otras; un plan de validación de equipos, sistemas y operativos; una correcta gestión de cambios; y la

realización de análisis de riesgo: con un sistema documental y formación de forma continuada.

En este sentido, la ampliación se ha hecho bajo los requisitos legales exigidos y el certificado de Buenas Prácticas en Distribución (BPD's) emitido por la administración sanitaria, esencial en agentes clave en distribución farmacéutica.

MEJORA DE LA EFICIENCIA CON LA INTEGRACIÓN DE ACTIBIOS

Con esta ampliación, Grup Fedefarma también mejora la eficiencia operativa en la distribución de marcas especializadas –ya totalmente integrada– a través de Actibios, mayorista líder en la distribución de este tipo de productos. Entre otras, se instalará una zona de repaquetado que permitirá preparar cajas personalizadas en la medida del producto con una capacidad de 900 cajas/hora. Esta máquina optimizará el proceso de packaging, reducirá el número de expediciones y mejorará la eficiencia operativa.



TÚ ERES NUESTRA PRIMERA ELECCIÓN

En Grup Fedefarma lo primero eres tú y queremos acompañarte. Con la fuerza de la distribución farmacéutica de Fedefarma y la especialización de Actibios. Con Mentora, el nuevo ecosistema formativo y con Assessora que te acompañamos en todo lo que necesitas.



www.grupfedefarma.com

La Cooperativa d'Apotecaris colabora en el plan de vacunación frente al nuevo serotipo 3 de la lengua azul

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural informó a principios del mes de octubre sobre la detección de diez focos activos del nuevo serotipo 3 del virus de la lengua azul en Mallorca. Ante esta situación, el Govern de les Illes Balears, en colaboración con las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), ha activado un plan de vacunación que concentra los esfuerzos en los municipios situados dentro de un radio de diez kilómetros alrededor del primer foco detectado en Bunyola.



En el marco de este plan, la Cooperativa d'Apotecaris colabora estrechamente con la Conselleria d'Agricultura en la gestión logística y operativa de las vacunas frente al serotipo 3. Gracias a su infraestructura logística y a la experiencia en la conservación de medicamentos, la Cooperativa garantiza que todo el proceso de recepción, control y almacenamiento de las vacunas se realice bajo las condiciones de seguridad y conservación adecuadas.

La Cooperativa, junto al Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), coordina

la gestión integral y conservación en condiciones óptimas de las vacunas SYVAZUL BTV 3, disponibles en presentaciones de 80 y 200 ml., destinadas a la inmunización de ovinos y bovinos. Cabe destacar que, en esta primera fase, la Conselleria dispone de un primer lote de 100.000 dosis, a las que se sumarán otras 100.000 dosis adicionales, con el objetivo de cubrir las zonas afectadas y prevenir la expansión de la enfermedad.

Esta colaboración entre la Cooperativa d'Apotecaris y la Administración no es nueva. Ya en 2021, ante la aparición inesperada de la lengua azul

en la comunidad autónoma, la Cooperativa activó de manera inmediata su red operativa y su capacidad logística para apoyar las actuaciones de emergencia veterinaria. Aquella experiencia consolidó el papel de la distribuidora como aliado estratégico del Govern en situaciones que requieren una respuesta sanitaria rápida, coordinada y eficiente.

Desde la Conselleria se recuerda que esta alerta no tiene ninguna incidencia sobre la salud pública. La lengua azul es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos del género Culicoides que afecta exclusivamente a rumiantes.

César Hernández, protagonista del primer *Encuentro FEDIFAR*

La Federación de Distribuidores Farmacéuticos impulsa esta iniciativa con el objetivo de crear un espacio de encuentro entre representantes de la distribución integral y personalidades del entorno sanitario.

La Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) celebró el pasado mes de noviembre la primera edición de los 'Encuentros FEDIFAR', una iniciativa impulsada por la patronal que tiene como propósito consolidar un espacio de encuentro destinado a reforzar la colaboración entre los principales actores del sistema sanitario y los máximos representantes de las empresas de distribución farmacéutica integral que operan en España.

Este primer encuentro contó con la participación de César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, quien expuso las principales novedades y proyectos en materia de medicamento y política farmacéutica.

Tras su intervención, se dio paso a un coloquio con los presidentes y directivos de las compañías asociadas a FEDIFAR, en el que

se abordaron temas clave y de actualidad para el sector, como las novedades regulatorias en marcha –particularmente la Ley del Medicamento–, las perspectivas de futuro del sector o el papel de la distribución farmacéutica integral en el sistema sanitario.

Bidafarma fortalece su proyección internacional al incorporarse a la IHCO

La International Health Cooperative Organisation (IHCO) ha aprobado por unanimidad la incorporación de Bidafarma como nuevo miembro de pleno derecho, reforzando la presencia de la cooperativa farmacéutica española en el escenario internacional de las organizaciones sanitarias y cooperativas.

La asamblea de la IHCO, celebrada el 15 de octubre, aprobó la incorporación de Bidafarma como nuevo miembro de esta organización internacional de referencia en el ámbito de las cooperativas sanitarias.

En el transcurso de la Asamblea General, la IHCO también celebró la elección de su nueva Junta Directiva para el periodo 2025-2029, que estará presidida por Carlos Zarco (España), presidente de la Fundación Espriu-Asisa. Le acompañarán como vicepresidentes Ricardo López (Argentina), de FAESS, y Hodaka Hara (Japón), de Health and Welfare Cooperatives.

La nueva Junta Directiva refleja la diversidad y el crecimiento de la red global de la IHCO, que actualmente representa a 22 organizaciones cooperativas de salud en 19 países de todos los continentes. Su misión es liderar los esfuerzos para fortalecer la contribución de las cooperativas de salud a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y avanzar en el cumplimiento del “**Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar**”.

La IHCO es una organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) que fomenta el intercambio de conocimiento, la defensa de intereses



comunes y la colaboración entre cooperativas de salud de todo el mundo.

La adhesión de Bidafarma fortalece su compromiso con el modelo cooperativo y su papel activo en la construcción de sistemas sanitarios más equitativos y sostenibles. Como cooperativa farmacéutica y miembro de pleno derecho de la ACI, Bidafarma representa a más de 10.000 farmacias en todo el territorio español y desarrolla su actividad con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, impulsando la sostenibilidad del sistema

“
La adhesión de Bidafarma fortalece su compromiso con el modelo cooperativo y su papel activo en la construcción de sistemas sanitarios más equitativos y sostenibles

sanitario y reforzando el papel esencial de la farmacia comunitaria en la atención a la salud de las personas.

La salud comienza en tu farmacia de confianza



**Somos cooperativa,
somos farmacia.**

bida
farma

De qué hablamos cuando hablamos de salud femenina

La cooperativa farmacéutica Novaltía reunió el pasado mes de octubre en el Palacio de Congresos de Zaragoza a 200 farmacéuticos en la I Jornada de Salud Integral Femenina "Una visión global de la salud y bienestar de la mujer".

Un encuentro que contó con ponentes de primer nivel que abordaron temas de máximo interés para la farmacia y para sus pacientes femeninas: nutricosmética efectiva, la realidad sobre el estrés oxidativo, nutrición y ejercicio en cada etapa de la vida, acompañamiento y cuidado de la mujer en el periodo no fértil, consejo y atención integral desde la farmacia, inflamaging, microbiota, mitos y realidades en nutrición para la mujer...

Farmacéuticas referentes del ámbito nacional como Marta Masi, Beatriz Saralegui, María Pérez Maldonado, Amaya Blanco, Miren Zamakola, Cristina Calvo Francia, Mónica Pérez o Tamar Troncoso fueron las encargadas de abordar los temas que hoy interesan a las farmacéuticas para actualizarse y atender a las pacientes en un entorno donde hay cada vez más información disponible y es necesario contar con un referente profesional que avale.

¿DE QUÉ SE HABLA CUANDO SE HABLA DE SALUD FEMENINA?

Como recogía la periodista Adriana Oliveros, conductora de la jornada, los asistentes se llevaron buenos aprendizajes: que la **nutricosmética** efectiva no está solo en los suplementos, como enseñó Beatriz Saralegui, sino en juntarse con mujeres que



suman; que el **estrés oxidativo**, según la doctora Lorena Vaquer, se combate con antioxidantes... y con sentido del humor; que Cristina Calvo recordó que no hay mejor **gimnasio** que la constancia; que gracias a Marta Masi, sabemos que de la **menopausia** hay que ocuparse, pero sin dramas (ni abanicos de emergencia); que Amaya Blanco y Miren Zamakola confirmaron que **comunicar** bien también es cuidar —y que los filtros se los dejamos a Instagram, no a la información—; que Tamar Troncoso advirtió que el **"inflamaging"** es como un gremlin: mejor no alimentarlo; que Mónica Pérez nos abrió el universo de la microbiota, ese grupo de amigas que sí queremos dentro; y que María Pérez Maldonado dejó claro que en nutrición no hay recetas mágicas... salvo la

de pensar un poquito antes de creerlo todo.

Mamen Martínez, subdirectora general de Novaltía y Unai Ortiz de Zárate, director comercial de la cooperativa, recordaron a los farmacéuticos por qué no es lo mismo trabajar con Novaltía que con otro distribuidor farmacéutico incidiendo en que el modelo cooperativo de Novaltía consigue que los socios sientan la cooperativa como suya, más que como un proveedor.

Un encuentro en el que se combinaron ciencia, inspiración y muchos motivos para seguir hablando —sin mitos, sin miedo y con mucha evidencia— de lo que de verdad importa: la salud de las mujeres y cómo desde la farmacia se puede acompañar para mejorar el bienestar femenino.

La fuerza de volar juntos

La unión nos hace únicos

Grupo Unnefar, la opción más natural y única del sector para las cooperativas de distribución farmacéutica que apuestan por mantener su identidad sin renunciar a la rentabilidad y al potencial de futuro que aporta un gran grupo.



unnefar.es

grupo
unnefar



Un compuesto experimental podría abrir nuevas vías para tratar el alcoholismo

Un nuevo compuesto ensayado en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) muestra efectos prometedores para reducir el consumo y la motivación por el alcohol.

Este es uno de los principales resultados de un estudio preclínico realizado en ratones, en el que se observaron diferencias relacionadas con la dosis según el sexo de los animales: los machos necesitaron cantidades más pequeñas que las hembras para obtener la eficacia del tratamiento. El compuesto, denominado MCH11, no está disponible todavía para su uso en humanos, pero podría abrir nuevas vías hacia tratamientos personalizados del trastorno por uso de alcohol.



Los resultados, publicados en la revista científica **Biomedicine & Pharmacotherapy**, son fruto de cuatro años de trabajo del laboratorio *Neuropsicofarmacología traslacional de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas*, que dirige Jorge Manzanares en el Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El equipo pertenece también al Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y a la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones (RIAPAD).

El trastorno por uso de alcohol es una de las adicciones más prevalentes a nivel mundial y causa 2,6 millones de muertes anuales. “Sin embargo, las terapias actuales están mostrando serias limitaciones”, apunta el investigador Abraham Torregrosa, primer autor del estudio, quien explica que **hasta un 70% de los pacientes reanudan el consumo de alcohol dentro del primer año de tratamiento.**

Para encontrar una terapia farmacológica más eficaz, los investigadores dirigieron su atención al sistema endocannabinoide, una red de señalización que conecta el sistema nervioso con el resto

del organismo y que participa en la regulación del placer, la motivación y el estrés, todos ellos procesos clave en la adicción al alcohol. En las personas con trastorno por uso de alcohol, este sistema se altera, reduciendo los niveles del endocannabinoide 2-araquidonilglicerol (2-AG), implicado en muchos procesos regulatorios cerebrales como la sensación de bienestar y en el control del impulso de consumo.

El compuesto MCH11 actúa inhibiendo la enzima monoacilglicerol lipasa, cuya función normal es metabolizar el 2-AG. Al bloquear esta enzima, aumenta la cantidad de 2-AG disponible en el cerebro, lo que reduce significativamente la motivación de beber alcohol. **“Nuestros resultados demuestran que MCH11 actúa sobre los mecanismos del sistema nervioso que ayudan a controlar el impulso de consumir alcohol, pero sin producir efectos secundarios indeseados”**, al menos en los ratones y a las dosis ensayadas, explica el

catedrático de la UMH Jorge Manzanares, líder del estudio. “Este hallazgo es particularmente relevante, porque los comportamientos impulsivos están estrechamente relacionados con el desarrollo y mantenimiento del alcoholismo”, añade.

DIFERENCIAS ENTRE MACHOS Y HEMBRAS

El tratamiento en ratones con MCH11 ha demostrado ser eficaz y selectivo: presenta propiedades ansiolíticas y antidepressivas sin afectar ni a la función motora ni cognitiva. No obstante, los experimentos revelaron diferencias significativas entre sexos. “En los machos, la respuesta al tratamiento fue efectiva con dosis bajas y medias, mientras que las hembras requirieron dosis más altas para obtener efectos similares”, explica Manzanares.

La mejoría se puede observar no sólo en el comportamiento de los animales, sino también a nivel genético. “Sabemos que ciertos genes se alteran con el trastorno por uso de alcohol, y hemos

comprobado mediante análisis de PCR que esas alteraciones se corrigen con MCH11 en ratones de ambos sexos, aunque las hembras necesiten una dosis mayor”, añade Torregrosa.

El equipo también probó un tratamiento combinado de MCH11 con topiramato, un medicamento que ya se utiliza clínicamente para tratar la adicción al alcohol. “Hemos comprobado que la combinación de ambos compuestos es la más efectiva”, apunta Manzanares, quien destaca el potencial de MCH11 como parte de una terapia combinada y personalizada, adaptada a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. “Los resultados son muy prometedores, pero aún preliminares”, explica el profesor de la UMH.

Referencia científica:

Torregrosa, A.B., García-Gutiérrez, M.S., Navarro, D., Navarrete, F. and Manzanares, J. (2025). MCH11, a new monoacylglycerol lipase inhibitor, reduces ethanol consumption and motivation to drink in mice, with sex-dependent differences. *Biomedicine & Pharmacotherapy*. DOI: doi.org/10.1016/j.biopha.2025.118662.

SUSPENSIÓN ORAL ANTI-REFLUJO

NUEVO

Tu estómago en calma

Alivio de los síntomas asociados al **reflujo gastroesofágico**

Bloquea el reflujo ácido

Reduce el ardor

Protege la mucosa del esófago

Producto sanitario

PROTAGONISTA

Iria Gabarra Pérez

Farmacéutica con experiencia en cooperación internacional



El Hospital Saint Jean de Dieu, situado en Afagnan, una localidad del sur de Togo, cuenta desde el pasado mes de junio con un laboratorio de formulación magistral cuya puesta en marcha está transformando por completo el funcionamiento diario de un centro que atiende anualmente a cerca de 10.000 personas.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación LASEMI Cooperación en colaboración con Juan Ciudad ONGD y Acofarma, entre otros organismos. Esta entidad sin ánimo de lucro, constituida por la Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LASEMI), desarrolla proyectos en países de África subsahariana para crear laboratorios de formulación magistral en hospitales, mejorar el servicio de farmacia y formar a profesionales autóctonos. Su actividad comenzó en 2022, en Senegal, optimizando el servicio de farmacia hospitalaria en el Hospital de Thiès. Detrás de esta última acción se encuentra la farmacéutica Iria Gabarra Pérez, quien recientemente ha finalizado un Máster en Salud Internacional y Cooperación. Tras meses trabajando codo a codo con el equipo local, Iria ha vivido en primera persona la puesta en marcha de este servicio. Con ella analizamos el impacto de esta actividad, el aprendizaje sobre el terreno y los retos que supone avanzar hacia un acceso más equitativo y justo a los medicamentos.

¿Cuál fue tu primer contacto con programas de cooperación en el ámbito farmacéutico?

Estudié Farmacia en la Universidad de Barcelona, y antes del Trabajo de Fin de Grado decidí apuntarme a un voluntariado en Senegal con la ONG *Tú en África*. Era una campaña de atención sanitaria en la que se montaban campamentos médicos. Los pacientes eran atendidos por médicos y enfermeras y yo me encargaba de entregar la medicación, como una farmacia de campaña. También realizábamos campañas de salud pública en colegios, abordando temas básicos como el lavado de manos y el cuidado dental, gracias a donaciones de materiales.

¿Has participado en otros proyectos de cooperación?

Sí, he estado en Senegal, Gambia y Sudáfrica. En Senegal conocí a la Fundación LASEMI Cooperación. Me presenté en una reunión que organizaban en la Universidad de Barcelona y les conté mi experiencia. Fue el primer paso para integrarme en el proyecto.

“

La formulación magistral es una herramienta muy potente en salud internacional y cooperación, pero poco extendida

¿Qué te motivó a involucrarte con LASEMI?

Todos los perfiles son necesarios: médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos... Yo quería explorar cómo podía contribuir desde la farmacia. La formulación magistral es una herramienta muy potente en salud internacional y cooperación, pero poco extendida. Además, ya había tenido experiencia en una farmacia de barrio –la Farmacia Selva, en Ripollet (Barcelona)– donde se formulaba, y me gustaba mucho.

Así empezó tu participación en la creación de un laboratorio en el Hospital Saint Jean de Dieu de Afagnan?

Sí, en 2024 dos miembros del equipo de LASEMI visitaron el hospital para evaluar su contexto, recursos y posibles alianzas. →

“

En África los hospitales no pueden acceder a los medicamentos en las mismas condiciones que otros países

Un año después, en junio de 2025, se inició la primera fase de desarrollo, con la habilitación y puesta en marcha del laboratorio. Además, gracias al apoyo de **Acofarma**, el hospital recibió una donación inicial de materia prima que permitió comenzar con la producción desde los primeros días de funcionamiento del laboratorio.

¿Cómo seleccionáis el país y el hospital en el que trabajáis?

LASEMI empezó sola, pero pronto se unió a la ONG Juan Ciudad (JCONGD), una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) creada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD), y que está vinculada a los hospitales San Juan de Dios.

Ellos ya tienen la infraestructura necesaria, conocen las leyes de cada país —lo que evita muchos trámites burocráticos— y disponen de una red de hospitales en África, lo que facilita mucho la implantación de proyectos al integrarnos directamente en centros que ya funcionan y atienden pacientes. Podemos centrarnos en montar el laboratorio y formar al personal sin tener que empezar desde cero.

¿Qué problemas has encontrado con el acceso a los medicamentos en los países dónde has estado?

Es un problema global, estructural y social. En África los hospitales no pueden acceder a los medicamentos en las mismas condiciones que otros países, lo que hace más vulnerable su sistema de salud. A los escasos recursos económicos de la población se suma la dependencia de la importación de fármacos, las frecuentes rupturas de stock y la falta de alternativas adecuadas.

En Togo, por ejemplo, el índice de desarrollo humano (IDH) es muy bajo, y la población no puede permitirse adquirir medicamentos, lo que fomenta el mercado ilegal con productos de dudosa calidad.

¿Qué situación encontrasteis en el hospital de Togo?

El hospital estaba bien organizado y la farmacia era la principal fuente de ingresos para mantener otros servicios. Sin embargo, los proyectos de formulación permiten optimizar recursos: por ejemplo, fabricar povidona yodada localmente reduce costes tanto para el hospital como para los pacientes, por lo que todo el mundo sale beneficiado.

IMPACTO DE LA FORMULACIÓN MAGISTRAL

¿Qué papel juega la formulación magistral en estos contextos?

Permite rebajar costes y adaptar tratamientos. En pediatría, por ejemplo, evita triturar comprimidos y cometer errores de dosificación. En Togo hemos empezado con 13 fórmulas básicas: jarabes pediátricos, cremas dermatológicas y soluciones antisépticas, seleccionadas en base a las necesidades identificadas durante reuniones con médicos, farmacéuticos y responsables del hospital. En Senegal, en el Hospital de Thiès, ya hay 43 descritas (cremas, jarabes, líquidos, cápsulas, estériles...), y se han producido 755 fórmulas entre junio 2024 y mayo 2025, más de la mitad de ellas destinadas a pediatría y neonatología. Además, tres hospitales derivan pacientes para acceder a jarabes formulados.

¿Qué retos técnicos y logísticos enfrentasteis al montar el laboratorio?

El hospital ya tenía la estructura física. Nosotros acondicionamos el espacio: construimos mobiliario, compramos materiales a nivel local y trajimos desde España equipamiento específico, como balanzas. También formamos a farmacéuticos, médicos y enfermeras, porque todos deben conocer las fórmulas.



¿Cómo fue la acogida de esta iniciativa por parte del personal local?

Muy buena, se nos prestó mucha atención desde el primer momento y se organizaron reuniones muy participativas. Además, contar con el respaldo de Acofarma y LASEMI ayudó a que se tomara este proyecto muy en serio desde el principio.

La implicación del equipo local ha sido máxima, desde el equipo médico hasta el servicio de almacén. Además, tuvimos la oportunidad de formar a varios técnicos en farmacia y farmacéuticos, sentando así las bases de un equipo estable y comprometido con la continuidad del laboratorio.

Lo más significativo es que el laboratorio no se vive como una estructura impuesta desde fuera, sino como una herramienta útil, plenamente integrada y gestionada por el propio hospital.

¿Existe alguna dificultad para garantizar la continuidad del proyecto?

El principal reto es el suministro de materias primas. Nos gustaría que en el futuro pudieran adquirirlas localmente o a través de proveedores fiables. De momento dependen de la cooperación, pero lo esencial es fortalecer la capacidad técnica y acompañar a los profesionales locales, que son altamente cualificados y comprometidos.

La verdadera cooperación pasa por reconocer su valor y facilitar que ellos mismos lideren soluciones sostenibles adaptadas a su contexto.

¿Qué impacto tiene el laboratorio en la atención farmacéutica del hospital?

Es pronto para medirlo, pero ya se han integrado varias fórmulas en la práctica diaria. En 2024 el hospital atendió a 9.656 personas, incluyendo pacientes de países vecinos como Benín, Ghana y Gabón.

Una de las primeras semanas de trabajo hubo una ruptura de stock de solución de Dakin, un antiséptico muy utilizado en diferentes servicios. Gracias a que el laboratorio ya estaba operativo y el equipo formado, en menos de tres horas fuimos capaces de asegurar el suministro para todo el hospital preparando más de 40 litros, demostrando que hay capacidad para dar una respuesta rápida a una emergencia.

¿Qué planes tenéis a largo plazo?

Que la propuesta crezca, que se puedan formular medicamentos más complejos, como cápsulas, y que se consolide una red de hospitales capaces de producir sus propios medicamentos de forma segura y eficaz.

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?

En septiembre se realizó un viaje de seguimiento para comprobar la implantación del laboratorio, y en diciembre la idea es activar la formulación de cápsulas, por ejemplo, de ivermectina, para ampliar la capacidad del hospital y el catálogo de fórmulas. El año que viene se prevén más viajes, según cómo evolucione el proyecto para garantizar su continuidad.

Gracias al aprendizaje en Senegal, el enfoque inicial se limita a fórmulas sencillas, con base sólida y formación clara, para crecer de forma segura y estructurada.

Las vitaminas B1, B6 y B12 en la práctica diaria

Dra. Laura Isabel Arranz, Doctora en nutrición, farmacéutica, dietista-nutricionista

Las vitaminas del complejo B desempeñan funciones esenciales en nuestro organismo y, aunque están muy presentes en los alimentos, en ocasiones puede haber una ingesta insuficiente o unos requerimientos aumentados por múltiples circunstancias. Es muy importante tenerlas en cuenta y valorar si estamos en niveles de ingesta óptimos para mantener nuestra salud.

Las vitaminas del grupo B son esenciales para un buen funcionamiento del metabolismo catabólico y anabólico. Aunque están presentes en muchos alimentos, estas ocho vitaminas hidrosolubles se excretan en la orina y, como no se almacenan en el organismo, requieren reposición adecuada diaria. Las vitaminas que forman el complejo B son: tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantoténico (B5), piridoxina (B6), biotina (B7), folato (B9) y cobalamina (B12). Actúan como coenzimas en múltiples procesos enzimáticos que contribuyen a todos los aspectos del funcionamiento fisiológico celular, incluyendo las principales funciones del cerebro, del sistema nervioso y del sistema inmunitario. Cualquier deficiencia de vitamina B puede afectar negativamente al metabolismo energético mitocondrial de aminoácidos, glucosa y ácidos grasos a través del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Por eso están tan vinculadas al beneficio de reducir el cansancio y la fatiga. Además, algunas de ellas están implicadas en el metabolismo del hierro y en el mantenimiento de los glóbulos rojos, con lo que contribuyen al correcto transporte de oxígeno por todos nuestros tejidos. Ayudan también a mantener niveles adecuados de homocisteína en sangre, cosa que protege nuestra salud cardiovascular y también son imprescindibles para tener un buen estado psicológico y emocional. Los síntomas de una ingesta insuficiente o de una deficiencia pueden ser muy variados y muchas veces en sus inicios pasan desapercibidos.



Entre todo el complejo de vitaminas B, las vitaminas B1, B6 y B12 se han usado en combinación para afecciones que tenían que ver con el dolor crónico o con afectaciones del sistema nervioso debido a su papel fundamental en el mantenimiento de la salud y funcionalidad de los nervios. →



Activa tu energía y abraza el bienestar con

B-Komplex

VITAMINAS DEL COMPLEJO B

Las vitaminas del complejo B participan en una multitud de procesos metabólicos importantes en el organismo y contribuyen significativamente a la salud y al bienestar general.

La sobrecarga nerviosa y la actividad física incrementan drásticamente la necesidad de vitaminas del grupo B. Los posibles síntomas de una carencia de vitaminas del complejo B son decaimiento, nerviosismo, irritabilidad, dificultad para concentrarse y escasa tolerancia al estrés. Especial atención tienen que prestarle a una suplementación correcta de vitamina B₁₂ los veganos, por la ausencia de carne en su alimentación.



- Ayuda al sistema nervioso
- Contribuye a disminuir el cansancio
- Apoya el metabolismo energético
- Mantiene sano pelo, piel y uñas



VITAMINA	SÍNTOMAS DE INGESTA INSUFICIENTE	SÍNTOMAS DEFICIENCIA
Vitamina B1	Fatiga, anorexia y alteración de la respuesta al estrés, irritabilidad, alteraciones del sueño.	Beriberi, endocarditis, arritmia y muerte súbita.
Vitamina B2	Fatiga, migraña.	Estomatitis, queilitis, glositis, dermatitis, irritación ocular, cataratas y anemia.
Vitamina B3	Depresión, ansiedad, pérdida de memoria.	Pelagra: dermatitis, fotodermatitis, ardor y espasmos en las extremidades y diarrea, síntomas psicóticos.
Vitamina B5	Alteraciones del sueño y cambios de comportamiento.	Diarrea, entumecimiento, sensación de ardor, dermatitis, encefalopatía, desmielinización.
Vitamina B6	Irritabilidad, pérdida de memoria.	Anemia, deterioro cognitivo, depresión, neuropatía periférica y convulsiones.
Vitamina B7	Fatiga, caída cabello.	Dermatitis y hormigueo en las extremidades, depresión, letargo y convulsiones.
Vitamina B9	Cambios en el estado de ánimo, alteración del equilibrio psicológico.	Anemia megaloblástica, neuropatía periférica y lesión de la médula espinal, cambios de conducta, trastornos afectivos, psicosis y demencia.
Vitamina B12	Cambios en el estado de ánimo, alteración del equilibrio psicológico.	Anemia megaloblástica, neuropatía periférica y lesión de la médula espinal, cambios de conducta, trastornos afectivos, psicosis y demencia.

LA VITAMINA B1 (O TIAMINA)

Es un cofactor esencial en el metabolismo de los carbohidratos y desempeña un papel fundamental en la generación del trifosfato de adenosina (ATP), moneda energética básica, a través de la vía de las pentosas fosfato y el ciclo de Krebs. Esta producción de energía es crucial para la función nerviosa, ya que las neuronas tienen una alta demanda energética. La deficiencia de tiamina puede provocar un deterioro significativo de la función nerviosa y déficits neurológicos, como la encefalopatía de Wernicke y el beriberi, afecciones caracterizadas por la degeneración nerviosa. En el contexto de los nervios periféricos, la deficiencia de tiamina altera la conducción axonal y el mantenimiento

de la mielina, lo que, en consecuencia, provoca síntomas neuropáticos.

La suplementación con tiamina puede mejorar los síntomas de la neuropatía diabética al mejorar la velocidad de conducción nerviosa y reducir el estrés oxidativo que suele estar elevado en las afecciones neuropáticas. Las propiedades antioxidantes de la tiamina son particularmente importantes para proteger los nervios de los efectos dañinos del estrés oxidativo que provoca la hiperglucemia en el contexto de la neuropatía diabética. Por lo tanto, mantener niveles adecuados de tiamina es esencial para cuidar la salud y funcionalidad de los nervios y para favorecer la regeneración nerviosa.

LA VITAMINA B6 (O PIRIDOXINA)

participa en la biosíntesis de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el ácido gamma-aminobutírico (GABA), todos ellos vitales para el correcto funcionamiento nervioso. La piridoxina también participa en el metabolismo de los aminoácidos, la producción de hemoglobina y la expresión genética. Su deficiencia se asocia con síntomas como irritabilidad, depresión y de-

terioro cognitivo, que a menudo se deben a una síntesis deficiente de neurotransmisores. En los nervios periféricos, la insuficiencia de vitamina B6 puede provocar una formación defectuosa de mielina, lo que provoca desmielinización y neuropatía. Parece que la suplementación con vitamina B6 puede reducir el dolor neuropático, especialmente en afecciones como el síndrome del túnel carpiano y la neuropatía diabética.

CUIDA TU ESPALDA CON

Bester Complex®

Prevención y tratamiento de déficit de vitamina B1, B6 y B12 que puede manifestarse como dolor de espalda



VITAMINA B12 (O COBALAMINA)

Es esencial para el mantenimiento de la mielina, la vaina protectora que rodea las fibras nerviosas. También desempeña un papel crucial en la síntesis de ADN y los procesos de metilación, importantes para la reparación y regeneración celular. Una deficiencia de vitamina B12 puede provocar diversos trastornos neurológicos, como la neuropatía periférica y la suplementación con vitamina B12 puede mejorar significativamente

los síntomas como la parestesia y los déficits motores, al promover la remielinización y mejorar la regeneración nerviosa. Además, se ha demostrado que la cobalamina mejora la síntesis del factor de crecimiento nervioso, una proteína esencial que participa en la supervivencia y el mantenimiento de las neuronas sensoriales y simpáticas. Este efecto neurotrófico subraya la importancia de la vitamina B12 no solo para prevenir el daño nervioso, sino también para facilitar la reparación de los nervios lesionados.

Aunque cada una tiene sus funciones, sus efectos sinérgicos son muy importantes. Las vitaminas B1, B6 y B12 suelen colaborar en las vías bioquímicas que favorecen la función nerviosa. Por ejemplo, la tiamina y la cobalamina participan en el metabolismo energético, mientras que la piridoxina y la cobalamina son cruciales para la síntesis de neurotransmisores y la integridad de la mielina. Por eso la suplementación combinada de estas vitaminas proporciona mayores efectos neuroprotectores en comparación con la suplementación vitamínica individual.

Son muchas las situaciones que pueden suponer un factor de riesgo para el déficit de vitaminas B y ante las que debemos estar atentos para optimizar nuestro consejo farmacéutico:

- Ingesta insuficiente por dietas restrictivas, dietas veganas (sobre todo para la vitamina B12), trastornos de la conducta alimentaria, etc.
- Alcoholismo.
- Quimioterapia.
- Pacientes inmunodeprimidos.
- Alteraciones gastrointestinales importantes que comprometen la absorción de nutrientes.
- Embarazo y lactancia.
- Hipertiroidismo y diabetes (aumenta el gasto o necesidad de vitaminas B).
- Diarreas que se prolongan en el tiempo.
- Uso de fármacos como los antiácidos, la metformina, los diuréticos, los barbitúricos o la isoniacida.
- Pacientes en diálisis.

Es necesario poner especial atención en personas que estén bajo ciertos tratamientos que son muy habituales y, además, crónicos como los antiácidos ya que reducen la absorción de la vitamina B12 y la metformina que reduce la absorción del ácido fólico



y de la vitamina B12. Estos tratamientos farmacológicos pueden ser necesarios a largo plazo, pero en ese caso debe contemplarse la recomendación de suplementos que puedan contrarrestar los niveles reducidos de estas vitaminas. También en casos de personas que sufren ciática, lumbago, herpes, dolores neuropáticos, dolores de espalda, otros dolores musculares o sensación de cansancio, podemos plantearnos que un buen complejo de vitaminas B puede ser de gran ayuda para apoyar las múltiples funciones de éstas en nuestro organismo.

Referencias

Hanna M, Jaqua E, Nguyen V, Clay J. B Vitamins: Functions and Uses in Medicine. Perm J. 2022 Jun 29;26(2):89-97. doi: 10.7812/TPP/21.204. Epub 2022 Jun 17. PMID: 35933667; PMCID: PMC9662251.

Cuyubamba O, Braga CP, Swift D, Stickney JT, Viel C. The Combination of Neurotropic Vitamins B1, B6, and B12 Enhances Neural Cell Maturation and Connectivity Superior to Single B Vitamins. Cells. 2025 Mar 22;14(7):477. doi: 10.3390/cells14070477. PMID: 40214431; PMCID: PMC11987730.

Calderon-Ospina CA, Nava-Mesa MO, Paez-Hurtado AM. Update on Safety Profiles of Vitamins B1, B6, and B12: A Narrative Review. Ther Clin Risk Manag. 2020 Dec 22;16:1275-1288. doi: 10.2147/TCRM.S274122. PMID: 33376337; PMCID: PMC7764703.

Paez-Hurtado AM, Calderon-Ospina CA, Nava-Mesa MO. Mechanisms of action of vitamin B1 (thiamine), B6 (pyridoxine), and B12 (cobalamin) in pain: a narrative review. Nutr Neurosci. 2023 Mar;26(3):235-253. doi: 10.1080/1028415X.2022.2034242. Epub 2022 Feb 14. PMID: 35156556.

DESDE EL MOSTRADOR

Los vapores terapéuticos de VapoRub Pomada



El 85% de consumidores confirma tener mayor alivio de sus síntomas al añadir VapoRub Pomada a su tratamiento para la gripe o resfriado², por lo que es una solución adecuada para aquellas personas que buscan un alivio de la tos y la congestión nasal.

En este contexto, es importante saber que con VapoRub Pomada no se han notificado interacciones con otros medicamentos para el tratamiento del alivio de los síntomas de la gripe y resfriado¹.

VapoRub Pomada contiene mentol, alcanfor, eucalipto, aceite de trementina y timol.

VapoRub Pomada es un medicamento que alivia la tos y congestión nasal asociada a gripe y resfriado¹, que tiene su origen hace más de 120 años.

Es conocido por muchos, pero lo que pocos saben y a menudo nos preguntan es: ¿cómo consigue VapoRub Pomada aliviar la tos y la congestión?¹

VapoRub Pomada contiene mentol, alcanfor, eucalipto, aceite de trementina y timol.

Esta combinación actúa como rubefaciente (causando hiperemia local que mejora la evaporación de aceites esenciales), antiséptico, descongestionante nasal y supresor de la tos, para uso tópico o inhalado, en resfriado común y gripe.



1. Ficha técnica Vaporub Pomada
2. Whiteford D, Rios J, Hengehold D, Aspley S. (2023) Multi-Symptom Relief for Cough & Cold: Benefits of Adding Vicks VapoRub to the Treatment Regimen. Open Journal of Respiratory Diseases, 13, 9-27.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES SANITARIOS. NO TRANSMITIR A CONSUMIDOR. Fecha de difusión: 01/09/2025. Medicamento no sujeto a prescripción médica. Medicamento no financiado. MAT-ES-VICKS-25-000037. Vaporub pomada 50g PVP: 10,49€. Vaporub pomada 100g, PVP: 15,49€. A partir de 6 años. Laboratorios Vicks, S.L.U
Ficha técnica de VapoRub Pomada: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/22051/FT_22051.html.pdf

El 78% de los productos tópicos de Acofarma son veganos

En un contexto en el que se incrementa la demanda de opciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, el 78% de los productos tópicos de parafarmacia de Acofarma ya son 100% veganos, elaborados con fórmulas libres de ingredientes de origen animal y con garantía de calidad farmacéutica.

El perfil del consumidor está evolucionando, y la adopción de la cosmética vegana le permite alinear sus hábitos de cuidado personal con sus valores éticos. Esto hace que cada vez más usuarios opten por productos que no contengan ingredientes de origen animal ni subproductos derivados de estos, lo que implica la reducción de la huella ecológica asociada a la ganadería. “En los últimos años Acofarma ha incorporado **fórmulas veganas** y con un **alto porcentaje de ingredientes de origen natural** en muchas de las gamas de cuidado personal, siempre manteniendo nuestro compromiso con la calidad farmacéutica”, explica Francesc Balletbó, director general de la empresa.

Una decisión que fortalece el posicionamiento estratégico de la marca en aspectos clave como el incremento de la confianza del consumidor, la diferenciación dentro del canal farmacia y una perspectiva de crecimiento positiva al estar en consonancia con demanda global del mercado. De hecho, la cosmética vegana es un sector en expansión, especialmente en Europa, donde ya supera el 30% de cuota de mercado y presenta una clara tendencia al alza.



GAMAS VEGANAS DE ACOFARMA

Actualmente, Acofarma cuenta con varias líneas de producto formuladas íntegramente sin ingredientes de origen animal:

- Toda la gama de **fotoprotectores tópicos Nesira** —faciales, corporales y pediátricos—, que ofrecen una alta protección contra los efectos nocivos de los rayos solares UVB-UVA, texturas ligeras y fórmulas adaptadas a cada tipo de piel.
- En cosmética corporal, **las lociones hidratantes Nesira** (indicadas para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles o muy secas), el **Aceite corporal de almendras dulces** y el **Body gel de aloe vera**, así como las **cremas de manos y pies**.

Todas ellas aportan hidratación duradera, confort y suavidad gracias a componentes como la **Flor de Tiaré** o el **aceite de oliva**.

- La línea de cosmética facial **Nesira**, compuesta por **Antiedad Global**, **Luminosidad** y **Reafirmante**, tres cremas formuladas con un alto porcentaje de ingredientes de origen natural y vegetal, como **ácido Hialurónico**, **vitamina E**, **resveratrol**, **coenzima Q10** o **aceite de argán**.
- La gama **Nesira** para el cuidado de **pieles atópicas**, formulada con ingredientes naturales —**bisabolol**, **extracto de caléndula**, **ceramidas** o **prebiótico**—, sin alérgenos y **testada dermatológica y pediátricamente**.

Además, en **higiene diaria**, se incluirían la gran mayoría de los **geles de baño**, así como **jabones de manos**, **champús** y **dentífricos**.

LA FARMACIA, ALIADA DEL CONSUMO CONSCIENTE

La incorporación de productos veganos en el canal farmacia responde a la demanda creciente de opciones *eco-friendly*, al tiempo

que refuerza el posicionamiento de este centro de salud como referente en cuidado responsable.

“En Acofarma entendemos que la sostenibilidad no es una moda, sino una necesidad. Integrar estos productos en la farmacia permite ofrecer soluciones alineadas con las expectativas del consumidor actual y ampliar la oferta sin comprometer calidad ni eficacia”, afirma Balletbó.

La empresa continuará desarrollando fórmulas respetuosas con la piel y el medio ambiente, consolidándose como una marca de referencia en la oficina de farmacia gracias a su amplio portfolio, que permite cubrir la mayoría de las necesidades del consumidor actual mediante un único proveedor.

Acofarma y LASEMI presentan un formulario de bases pionero que devuelve la autonomía técnica y clínica al farmacéutico

Acofarma patrocina el Formulario de Bases. Dermatología y formulación: soluciones individualizadas, elaborado por LASEMI y presentado el pasado 7 de noviembre en Sevilla. Coordinado por Luis Alberto Jiménez Labaig, esta herramienta técnica, práctica y actualizada reúne 35 bases dermatológicas que permiten al farmacéutico personalizar los excipientes para que se adapten a diferentes tipos de activos, patologías, zonas de aplicación y características del paciente.

Acofarma, compañía de referencia en la distribución de materias primas y soluciones para la formulación magistral, ha participado como patrocinador en la elaboración y presentación del nuevo **Formulario de Bases. Dermatología y formulación: soluciones individualizadas**, una publicación técnica promovida por la **Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LASEMI)** y presentada oficialmente durante la **I Jornada de Dermatología y Formulación: soluciones individualizadas** celebrada el pasado 7 de noviembre en Sevilla.

Este formulario de bases nace con el objetivo de **ofrecer a los farmacéuticos formulistas una herramienta rigurosa, práctica y actualizada**, que recupera el

conocimiento técnico necesario para la preparación de sus propios excipientes. “En los últimos años, la formulación dermatológica se ha apoyado con frecuencia en bases industriales preelaboradas. Esto ha simplificado la práctica, pero ha reducido la autonomía técnica del formulador”, afirma **Luis Alberto Jiménez Labaig**, coordinador del proyecto, farmacéutico formulista y director técnico-científico de LASEMI.

En este contexto, este formulario nace con la intención de devolver al farmacéutico la posibilidad de **diseñar vehículos propios, con criterios de calidad, reproducibilidad y evidencia científica**, adaptando cada base a las necesidades del paciente y al principio activo. “Además, **responde a una demanda real de dermatólogos**

y **farmacéuticos**, que pedían una guía moderna, rigurosa y accesible para personalizar tratamientos dermatológicos”, añade Labaig.

El diseño cerrado que ofrecen las bases industriales implica que el formulador no puede modificar su composición, su pH o su proporción de fases sin comprometer la estabilidad.

“Esto limita el ajuste del excipiente a las propiedades del principio activo, a la localización de la lesión o al tipo de piel del paciente. Además, no permiten optimizar parámetros como la liberación, penetración, bioadhesividad o cosmetividad, que son determinantes para la eficacia y la adherencia al tratamiento”, afirma el coordinador del proyecto. —>



En definitiva, la preparación de bases vehiculares propias favorece la autonomía técnica del profesional y refuerza la calidad del medicamento individualizado en dermatología.

IMPACTO TÉCNICO Y CLÍNICO

Según Luis Alberto Jiménez Labaig, el impacto de esta obra en la práctica diaria de los formulistas y en la calidad asistencial al paciente dermatológico va a tener una doble vertiente: técnica y clínica.

Desde el punto de vista técnico, el formulario proporciona 35 bases **galénicas de uso dermatológico** seleccionadas por su utilidad clínica y versatilidad para ser adaptadas a diferentes tipos de activos, patologías, zonas de aplicación y características del paciente.

Cada una de ellas se presenta en una ficha técnica en la que aparece descrita con precisión, además de contener su composición detallada, procedimientos de elaboración, control de calidad, criterios organolépticos, condiciones de conservación y referencias científicas. Para Labaig, “esto da al formulista una herramienta fiable y formativa, que le permitirá elaborar sus propios vehículos con seguridad y uniformidad.”

Desde el punto de vista clínico, supone mejorar la eficacia y

tolerabilidad de los tratamientos tópicos. “Cada base puede adaptarse al tipo de piel (seca, grasa, sensible, inflamada...), al área anatómica y al objetivo terapéutico. En definitiva, se potencia la individualización y se mejora la adherencia del paciente al tratamiento”, matiza este formulista.

NECESIDADES TERAPÉUTICAS CUBIERTAS

El formulario incluye bases que cubren prácticamente todo el espectro dermatológico, desde patologías inflamatorias y descamativas hasta cuadros infecciosos, seborreicos o de piel sensible.

Para ello se han seleccionado cremas clásicas, como la base Beeler, cetomacrogol, *cold creams* o Lanette, junto con emulsiones glucídicas, siliconadas, espumas (capilares y corporales), aceites, excipientes adhesivos orales, mascarillas, geles bioadhesivos y otras formulaciones con interés clínico e innovador.

Esto permite formular desde tratamientos emolientes y reparadores hasta vehículos ligeros para afecciones como el acné, la rosácea o la dermatitis seborreica, pasando por bases más oclusivas para psoriasis o xerosis intensa. “Las patologías que más se benefician de la personalización son aquellas en las que el tipo de piel, la localización o la cronicidad del

proceso exigen ajustar la textura, la hidratación y la liberación del activo: acné, dermatitis atópica, psoriasis, piel sensible o piel envejecida”, confirma este experto.

La iniciativa cuenta con la participación de un destacado equipo de farmacéuticos formulistas —entre ellos **Edgar Abarca, Martín Muñoz, Gorka Urruzuno, Elena Manso, Tomás Abascal, Marta Uriel, Santiago Gómez, Irene Palacio y Martín Ramírez**—, todos ellos miembros de LASEMI y referentes en la docencia, la formulación y la investigación.

Como patrocinador del proyecto, **Acofarma** ha querido poner en valor la importancia de la colaboración entre entidades científicas y profesionales con la industria farmacéutica para potenciar el futuro de la formulación magistral.

Esta vinculación cobra especial relevancia en un momento en que en España el mercado de la formulación está sufriendo un proceso de concentración en manos de empresas multinacionales. “En Acofarma llevamos más de 75 años defendiendo el modelo de farmacia comunitaria porque somos parte de él. Somos propiedad de la distribución farmacéutica cooperativista, y eso nos permite tomar decisiones pensando siempre en las necesidades de los farmacéuticos, no en intereses empresariales”, señala Francesc Balletbó, director general de la empresa.

Disponible tanto en formato digital como en edición impresa, el Formulario de Bases puede consultarse y adquirirse a través del sitio web de LASEMI (lasemi.es) y de la web acofarmashop.com.

El control y la prevención, claves frente a la diabetes tipo 2

Acofarma lanza un nuevo Sistema de monitorización de glucosa en sangre* diseñado para pacientes con diabetes tipo 2 o con riesgo de desarrollarla, una herramienta precisa y fácil de usar para la prevención de complicaciones y el seguimiento eficaz de la enfermedad.

La empresa refuerza su compromiso con la salud y el bienestar de los pacientes con el lanzamiento del **nuevo Sistema de monitorización de glucosa en sangre Acofar**, diseñado específicamente para personas con **diabetes tipo 2** o con riesgo de desarrollarla. El dispositivo, disponible exclusivamente en farmacias, combina **precisión, rapidez y facilidad de uso**, simplificando el autocontrol de la glucemia y empoderando el

papel del paciente en la prevención y seguimiento de esta enfermedad crónica.

LA DIABETES TIPO 2, UN RETO CRECIENTE EN ESPAÑA

Según datos de la **Fundación Diabetes Cero**, el pasado año cerca de 3,5 millones de personas **padeían diabetes** en España, lo que representa el **7,5% de la población total**. De ellas, **más del 90% padece diabetes tipo 2**, la

forma más frecuente de la enfermedad, vinculada a factores como **el envejecimiento, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad**.

Aunque la diabetes tipo 1 crece a un ritmo del 2,5% anual, la **diabetes tipo 2 mantiene un aumento sostenido del 2,2%**, muy por encima del crecimiento poblacional (0,6 %), lo que evidencia su expansión y la necesidad de implementar medidas preventivas eficaces. →

Reishinua®

El gran aliado de tu bienestar respiratorio

- ✓ Vitamina C
- ✓ Reishi Shitake
- ✓ Jalea Real

nua biological

www.nuabiological.com



“
La automedición facilita la
prevención de hipoglucemias
e hiperglucemias y el ajuste
terapéutico individualizado

El impacto de la enfermedad va más allá de los niveles de glucosa:

- Las personas con diabetes tienen **tres veces más riesgo de enfermedad cardiovascular**.
- **1 de cada 3** puede desarrollar algún tipo de pérdida de visión.
- La **insuficiencia renal** es **10 veces más frecuente** entre las personas con diabetes.
- Cada **30 segundos**, se produce en el mundo una **amputación** relacionada con complicaciones diabéticas.

El control regular de la glucemia es, por tanto, una herramienta fundamental para **reducir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida**.

LA IMPORTANCIA DEL AUTOCONTROL GLUCÉMICO

La **monitorización periódica de la glucosa** permite al paciente comprender cómo influyen en su organismo la dieta, el ejercicio o la medicación, y ayuda al profesional sanitario a **ajustar el tratamiento** de forma más precisa.

Según la **International Diabetes Federation**, mantener los niveles de glucosa dentro del rango objetivo puede **reducir en un 40% el riesgo de complicaciones** oculares, renales y neurológicas.

Además, la automedición facilita la **prevención de hipoglucemias e hiperglucemias y el ajuste terapéutico individualizado**. A esto se suma que incrementa la **adherencia al tratamiento** y aumenta la **autonomía y comprensión** del paciente sobre su enfermedad.

En este contexto, contar con dispositivos sencillos, precisos y accesibles resulta esencial para una atención eficaz.

EL NUEVO SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA ACOFAR

El **Glucómetro Acofar** ha sido desarrollado para ofrecer una experiencia de uso cómoda y fiable para el paciente. Con un diseño fácil e intuitivo, su tecnología garantiza **resultados rápidos y precisos en sólo 5 segundos**, con una mínima muestra de sangre (0,5 µL).

Entre las principales **características** del sistema destacan su **indicación para pacientes con diabetes tipo 2** y su **presentación en un pack completo** que incluye **un glucómetro, un dispositivo de punción, 10 lancetas y 25 tiras reactivas de regalo**.

El dispositivo presenta un **rango de medición de 20 a 600 mg/dL**, e incorpora **bolsa de transporte y soporte de silicona**. Además, las **lancetas Acofar son compatibles con dispositivos de calibre 30G**.

Estas prestaciones han alzado al glucómetro Acofar (antes Nesira) al **segundo puesto en ventas en España**, según datos a cierre de septiembre de la consultora IQVIA, asentándose como una de las opciones más elegidas por las farmacias y los pacientes.

El nuevo **Sistema de Monitorización de Glucosa Acofar** se suma a la gama de productos de autodiagnóstico de la marca, contribuyendo a que cada paciente **mantenga el control de su salud** y ofreciendo la farmacia herramientas para que se consolide como un espacio de prevención y educación sanitaria.

*Este producto cumple con la normativa sobre productos sanitarios.

Acofarma renueva el certificado GMP que garantiza la calidad de sus materias primas

Acofarma ha obtenido la renovación del certificado de cumplimiento de las Normas de Correcta Fabricación (GMP, por sus siglas en inglés), un reconocimiento que certifica su adecuado sistema de calidad en el fraccionamiento y la distribución de materias primas destinadas a la elaboración de fórmulas magistrales.

El certificado, otorgado por la autoridad sanitaria competente, avala la solidez del modelo de gestión y control del laboratorio, y reafirma su compromiso con **la seguridad, la trazabilidad y la calidad farmacéutica**, pilares que han guiado su actividad durante más de 75 años.

Según **Francesc Balletbó, director general de Acofarma**, “esta renovación llega en un momento clave para la compañía. En España, el mercado de la formulación está viviendo un proceso de concentración en manos de grandes multinacionales, mientras que nosotros seguimos defendiendo el actual modelo de **farmacia comunitaria**, porque somos parte de él. Ser propiedad de la **distribución farmacéutica cooperativista** nos permite tomar decisiones pensando siempre en las **necesidades reales de los farmacéuticos**, no en intereses empresariales.”

UNA VÍA DE CRECIMIENTO PARA LAS FARMACIAS

La **formulación magistral**, que permite la personalización de medicamentos para adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente, es un elemento diferenciador en la atención al paciente por parte del farmacéutico, además de representar una **oportunidad de crecimiento y rentabilidad para la farma-**



cia. En palabras de **Montserrat Enrique, directora técnica de Acofarma**, “nuestro sistema de calidad, fundamentado en los estándares de las GMP’s, garantiza la adecuada calidad de nuestras materias primas para que el farmacéutico pueda elaborar medicamentos personalizados con total seguridad.”

PRESENCIA INTERNACIONAL Y APUESTA POR LA FORMULACIÓN MAGISTRAL

En base a esta filosofía la empresa mantiene su compromiso de **acompañar a los profesionales de farmacia** a través de diferentes actividades de formación, como el patrocinio del Programa Nacional de Formación Continuada en Formulación Magistral del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, o cursos impartidos por Colegios de Farmacéuticos locales y asociaciones de formulistas.

Además, cuenta con su **plataforma propia de formación online** (formacion.acofarma.com).

A esto se suma que Acofarma continúa **ampliando su presencia internacional**, con **Portugal** o **Francia** como algunos de sus mercados más relevantes. El compromiso de estos países con la promoción de esta práctica ha llevado a Acofarma a organizar el pasado **20 de noviembre** una formación, **Simpósio Formulação Magistral em Foco**, en la sede de LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos) en la ciudad de **Lisboa**. “El crecimiento en Portugal es una muestra de cómo otros mercados reconocen el valor de nuestro modelo de negocio, basado en la cercanía con la farmacia y en la defensa del medicamento personalizado como herramienta terapéutica esencial”, concluye Balletbó.

Tapones de cerumen: cómo cuidar los oídos para evitarlos

Eulalia Mateu, Farmacéutica y miembro de la vocalía de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB)

El cerumen, conocido comúnmente como cera del oído, es una sustancia cerosa producida de manera natural en el conducto auditivo externo de los seres humanos.

El cerumen es una secreción lipídico-proteica compleja producida por las **glándulas ceruminosas y sebáceas** ubicadas en el tercio externo del conducto auditivo externo. Las glándulas ceruminosas son glándulas apocrinas modificadas, derivadas embriológicamente de glándulas sudoríparas, que secretan un fluido rico en lípidos y proteínas. Este se combina con la secreción sebácea y con **células epiteliales descamadas** para formar el cerumen.

El cerumen está constituido por:

- **Lípidos:** ésteres de colesterol, ácidos grasos libres, alcoholes de cadena larga, escualeno y triglicéridos.
- **Proteínas:** aminoácidos y enzimas, incluyendo lisozima y otras enzimas con actividad antimicrobiana.
- **Componentes celulares:** restos de queratina, fragmentos de membrana y detritos celulares.
- **Otros compuestos:** sales minerales y compuestos volátiles.

El pH del cerumen es ligeramente ácido ($\approx 4,5-5,5$), característica que contribuye a su acción antimicrobiana.

Tipos de cerumen

Existen dos fenotipos principales de cerumen humano:

- **Húmedo:** más pegajoso y oscuro; común en personas de ascendencia africana y europea.
- **Seco:** más claro y escamoso; frecuente en poblaciones del este asiático y nativo americanas.

Esta diferencia está determinada por una variación genética en el gen ABCC11.

¿QUÉ FUNCIONES FISIOLÓGICAS REALIZA EL CERUMEN?

El cerumen no es simplemente un residuo pasivo, sino que cumple una serie de funciones fisiológicas en el microambiente del conducto auditivo, esenciales para la salud del oído.

1. Función de barrera física

Forma una película hidrofóbica en la superficie del epitelio del conducto auditivo que impide la entrada de agua, polvo, microorganismos y partículas exógenas, contribuyendo a mantener la integridad del epitelio auditivo impidiendo su llegada al tímpano.

2. Función antimicrobiana

Su composición lipídica y su pH ácido inhiben la proliferación de bacterias y hongos. Contiene lisozima, lactoferrina y ácidos grasos de cadena corta, con propiedades bacteriostáticas y fungistáticas.



OIDOS TAPONADOS

CERUMENOL

CERUMENOL

Gotas óticas

FRASCO DE 10 ml

Indicaciones, dosis, y método de administración: leer cuidadosamente las instrucciones de utilización.

Advertencias y precauciones: leer cuidadosamente las instrucciones de utilización.

PRODUCTO SANITARIO

CE

C.N. 185261.8

8 437014 372007

Desma

Cumple con la normativa de productos sanitarios.

anejp

ES-2023-02-CERU-01

Prevencción y eliminación de tapones de cera

INDICADO EN:

Personas mayores

Deportes de montaña

Personas con audífonos

Deportes de agua

Viajes en avión

- No usar este producto sanitario en niños menores de 12 años.
- Evitar el contacto con los ojos.

Consultar al médico en los siguientes casos:

- Cuando existan lesiones conocidas o sospechadas del oído o eliminación de la membrana timpánica.
- Empeoramiento de los síntomas causados por la tapa de cerumen.
- Ardores persistentes.

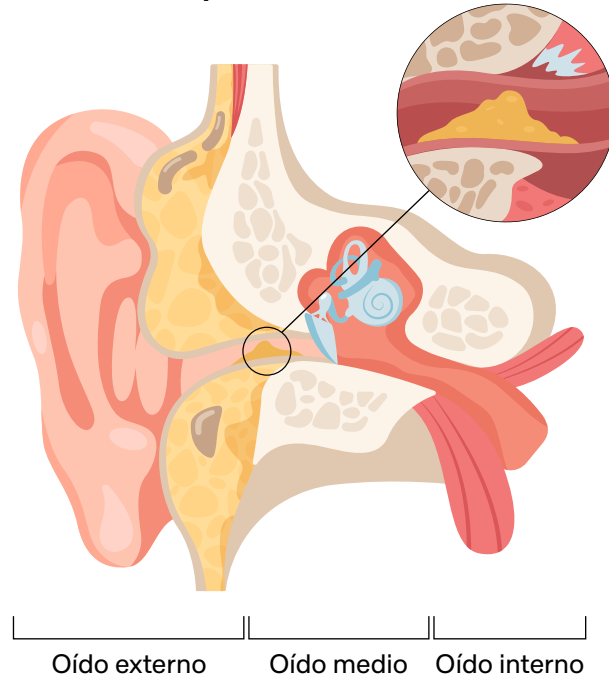
Producto Sanitario

Composición Con hidróxido de potasio, etanol y glicerol | **C.N. 185261.8**

Desma

Laboratorios Farmacéuticos S.L.

Obstrucción por cerumen



3. Función lubricante y de mantenimiento del epitelio

Los lípidos del cerumen ayudan a mantener la hidratación y elasticidad del epitelio del conducto auditivo, disminuyendo la fricción mecánica y protegiendo frente a microtraumatismos e irritaciones y contribuyen también a prevenir la aparición de fisuras y la descamación excesiva del epitelio.

4. Función autolimpiante

Gracias al proceso de migración epitelial hacia el conducto auditivo externo, junto con los movimientos mandibulares (habla, masticación), el cerumen arrastra detritos celulares y contaminantes hacia el exterior, constituyendo un mecanismo de limpieza pasiva que evita la acumulación y compactación del cerumen en condiciones normales.

5. Regulación del microambiente auditivo

El cerumen participa en la homeostasis química y microbiológica del conducto auditivo, manteniendo un ambiente ácido, húmedo y estable, desfavorable para la colonización microbiana patógena.

El cerumen se acumula cuando este proceso de autolimpieza no funciona correctamente. Esto puede ocurrir por el uso regular de bastoncillos con punta de algodón, la manipulación digital del conducto auditivo o el uso de audífonos, que pueden comprimir el cerumen profundamente en el conducto auditivo.

Desde el punto de vista clínico, la acumulación excesiva o impactación de cerumen puede causar: *hipoacusia conductiva reversible* (disminución del nivel de audición por trastorno en la conducción del sonido hacia el oído interno), *acufenos o tinnitus* (términos sinónimos que aluden a la percepción de sonidos que no tienen fuente externa, lo que hace que otras personas no puedan escucharlos. Los afectados suelen describirlos como un timbre, zumbidos o rugidos), así como prurito y *otalgia* (dolor de oído).

EDUCACION SANITARIA EN EL CUIDADO DEL OÍDO

El cerumen, como hemos visto, cumple unas funciones fisiológicas muy importantes, pero no así la acumulación excesiva de cerumen. Esta acumulación es un problema que puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad, dado que existen sujetos cuyas glándulas ceruminosas y sebáceas producen más cera de la que pueden eliminar de manera natural.

Por consiguiente, la higiene del oído ha de ser un acto especialmente cuidadoso, ya que se trata de un órgano que debe tratarse con precaución. Los hábitos incorrectos pueden acabar provocando daño en el oído o la acumulación del cerumen en el fondo del conducto auditivo externo creando los conocidos "tapones". Esto puede ocurrir por el uso regular de bastoncillos con punta de algodón, la manipulación digital del conducto auditivo o el uso de audífonos, que pueden comprimir el cerumen profundamente en el conducto auditivo.

A pesar de que limpiar los oídos con **bastoncillos de algodón** es una práctica muy común y se realiza pensando que sirve para eliminar el exceso de cera en los oídos, sucede más bien al contrario, ya que a menudo sólo empujan el cerumen más profundamente causando acumulaciones y bloqueos en el conducto auditivo. →

SPRAY ÓTICO



- Limpia y lubrica el conducto auditivo externo.
- Suaviza el cerumen para facilitar su extracción.
- Respetuoso con la microbiota del canal auditivo.
- Previene la formación de tapones de cerumen.





A este respecto cabe señalar que en 2019, la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico de un solo uso en el medio ambiente, entre ellos los bastoncillos de algodón –definidos como “palillo de vástago de plástico recubierto de algodón por una o por las dos puntas, de un solo uso, empleado a menudo para la higiene personal, especialmente para limpiar las orejas o aplicar maquillaje”–, prohibió su comercialización a partir del 3 de julio de 2021.

En España, dicha normativa se transpuso en la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, que prohíbe entre otros productos, la introducción en el mercado de bastoncillos de algodón con vástago de plástico (excepto los destinados a uso médico).

En cumplimiento de dicha normativa, actualmente se comercializan bastoncillos de algodón con vástago de algodón o bambú, aunque su uso para la limpieza de los oídos debería ser muy restringido para evitar los problemas mencionados anteriormente.

Además, la introducción de objetos en el oído puede causar pequeñas lesiones en la delicada piel del canal auditivo o incluso perforar el tímpano si se introducen demasiado. Los médicos otorrinolaringólogos desaconsejan su uso.

Por todo ello, es conveniente realizar una prevención de la acumulación excesiva de cerumen realizando una adecuada **higiene diaria ótica** con productos formulados para tal fin, y en el caso de que se hayan formado tapones de cerumen, será necesario el **empleo de productos cerumenolíticos**, que reblandezcan y ayuden a disolver el tapón y favorezcan al mismo tiempo la hidratación del conducto auditivo para mantener la buena audición y acabar con el exceso de cerumen.

HIGIENE ÓTICA Y PRODUCTOS CERUMENOLÍTICOS

Higiene ótica

La higiene de los oídos es muy importante, y aunque muchas personas tienen la percepción de que deben limpiar profundamente el canal auditivo, en realidad esto no siempre es necesario y, de hecho, puede ser hasta perjudicial.

En el caso de la higiene ótica, es conveniente realizar una prevención con productos a base de agua de mar purificada y estéril de concentración salina isotónica. Esta agua de mar, rica en oligoelementos, proporciona una serie de beneficios, tales como:

• Hidratación y fluidificación del cerumen

Ablanda suavemente el cerumen, facilitando su eliminación natural.

Favorece el mecanismo de autolimpieza epitelial mediante la migración natural del cerumen hacia el exterior.

Su uso regular reduce la acumulación de cerumen y, por tanto, la formación de tapones.

• Mantenimiento del equilibrio fisiológico

No interfiere con el pH ácido ($\approx 4,5-5,5$) del conducto auditivo, preservando su microbioma protector.

• Aporte de oligoelementos naturales

Algunos oligoelementos presentes, como el zinc y el selenio, pueden favorecer la regeneración epitelial.

El agua de mar isotónica es bien tolerada incluso en niños mayores de 6 meses y ancianos. Se presenta en forma de spray con boquilla aplicadora que se adapta perfectamente a la forma del oído y que permite administrar la cantidad precisa de producto en cada aplicación.

Productos cerumenolíticos

Si ya existe un tapón de cerumen, se han de emplear productos que combinen diversos activos cerumenolíticos –disolventes del cerumen– como pueden ser:

• Liberadores de oxígeno activo

El peróxido de hidrógeno o el peróxido de carbamida liberan oxígeno en contacto con el cerumen lo fragmenta, separándolo de las paredes del conducto auditivo.

• Tensioactivos suaves

Los más utilizados son Docusato sódico y Etoxidiglicol que reducen la tensión superficial del cerumen y disgregan la matriz lipídico-proteica.

• Activos saponificantes

Hidróxido de potasio a muy baja concentración, dado que aumenta el pH local y provoca la saponificación de los lípidos del cerumen, lo que reduce la viscosidad y cohesividad de la mezcla ceruminosa. Debido a su naturaleza alcalina, su uso está indicado frente a tapones muy compactos.

• Activos emolientes y humectantes

Aceites minerales y vegetales, como los aceites de almendra, de oliva, de ricino o aceite vegetal de hueso de albaricoque, que lubrican y disuelven parcialmente los componentes grasos del cerumen y reducen su adherencia al epitelio del conducto auditivo.

Glicerina (glicerol), que ablanda el cerumen al absorber agua y aumentar la plasticidad de este.

• Otros activos cerumenolíticos

Esencia de trementina, disolvente lipofílico que solubiliza los componentes grasos y cerosos del cerumen.



Clorobutanol, contribuye a disolver cerumen por su naturaleza anfifílica, reduciendo tensión superficial y reblandeciendo la matriz lipídica.

Etanol, coadyuvante en la disolución de componentes lipofílicos del cerumen.

Fenol, actúa desnaturalizando proteínas queratinicas y lípidos del cerumen, facilitando su ablandamiento y fragmentación. Posee además efecto antiséptico frente a ciertas bacterias.

Su presentación habitual es en forma de spray con boquilla aplicadora, o de gotas óticas con dosificador. No deben emplearse en niños menores de 3 años, y en el caso de algunos activos como el hidróxido de potasio, no aplicar a menores de 12 años.

Hay que tener en cuenta que el uso indiscriminado de sprays o gotas óticas puede alterar el microbioma auditivo local y predisponer a infecciones.

No deben utilizarse en caso de *otitis* (inflamación de alguno de los tejidos del oído), perforación del tímpano y, en general, en todas aquellas personas que tengan o hayan tenido antecedentes médicos a nivel del oído o del tímpano (vértigos, intervenciones médicas o quirúrgicas, etc...).

CRITERIOS DE DERIVACION AL MÉDICO

En caso de otalgia, otitis o si el tapón de cerumen persiste después de haber utilizado productos cerumenolíticos es importante derivar al médico de atención primaria o al otorrinolaringólogo.

Desde la trinchera del mostrador: persigue tu sueño

José Ramón García Soláns, farmacéutico comunitario en Zaragoza

“¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.”

Con “sueños son”, ¿quería Calderón decirnos que era algo de fantasía, inalcanzable? ¿Qué es más real: lo que vivimos o lo que soñamos? A veces son pesadillas de las que nos alegramos de despertar, a veces, ¿ánhelos irreales?

En la Biblia, los sueños anticipan destinos y pactos divinos; en Alicia en el país de las maravillas es un viaje onírico que desarma la lógica adulta; para Poe, en su “Sueño dentro de un sueño” (con o sin la banda sonora de Alan Parsons), es arena que se escurre entre los dedos, epifanía de lo inasible. ¿Sueñan los androides con ovejas metálicas? Relato de Philip K. Dick que da lugar a Blade Runner.

Vale, creo que queda claro que, incluso sin haber incluido el “Sueño de una noche de verano”, los seres humanos valoramos el sueño. Y el fisiológico lo necesitamos incluso más.

¿PARA QUÉ NECESITAMOS DORMIR?

El sueño, más que un “descanso”, es el **equipo nocturno de mantenimiento integral**.

Mientras dormimos, el cuerpo y el cerebro se ponen manos a la obra en una lista de tareas que no pueden ejecutarse durante la vigilia.

1. El cerebro: limpieza, reorganización y reciclaje

Durante el sueño, especialmente en las fases profundas (N3) y REM, el cerebro realiza una auténtica limpieza neuroquímica:

- **Sistema glinfático***: se abre el drenaje del líquido cefalorraquídeo y “lava” los desechos neuronales (como proteínas beta-amiloides, implicadas en el Alzheimer).
- **Consolidación de la memoria**: las experiencias del día se reordenan y archivan; se desechan datos irrelevantes.
 - El hipocampo “exporta” recuerdos a la corteza.
- **Plasticidad sináptica**: se refuerzan conexiones útiles y se debilitan las redundantes.
- **Sueños REM**: integran emociones, creatividad y aprendizaje (por eso a veces “resolvemos” un problema al dormir).
- **Regulación emocional**: el sueño equilibra la respuesta al estrés y modula la amígdala.

2. Músculos y tejidos: reparación y regeneración

Durante la vigilia, estamos en modo “gasto”. Al dormir, cambiamos a modo “reparación”:

- **Liberación de hormona del crecimiento (GH)**: repara tejidos, estimula síntesis proteica y regeneración muscular.
- **Recuperación y regeneración celular**.
- **Se reponen reservas de glucógeno en hígado y músculo**.
- **Se regula el metabolismo energético**.



3. Hígado y metabolismo: el turno de noche bioquímico

El hígado trabaja intensamente mientras dormimos:

- **Síntesis de colesterol y ácidos biliares**: durante el reposo, el hígado fabrica colesterol endógeno, necesario para hormonas esteroideas y membranas celulares.
 - Por eso las **estatinas de vida corta** (simvastatina, lovastatina, fluvastatina) se administran **por la noche**, coincidiendo con el pico fisiológico de síntesis.
- **Reposición de glucógeno hepático**.
- **Regulación de la sensibilidad a la insulina**.
- **Ajuste hormonal** (leptina, grelina, cortisol, melatonina).
- **Mantenimiento de la homeostasis energética**.

4. Corazón y sistema vascular: el descanso del motor

- Durante el sueño profundo, la presión arterial puede bajar un **10-20%** (el llamado “fenómeno dipper”).
- El corazón recupera su **tono parasimpático**, reduciendo la carga adrenérgica.
- Disminuye la **frecuencia cardíaca** y el **consumo miocárdico de oxígeno**.
- El ritmo circadiano cardiovascular se reajusta: el aumento matutino de cortisol y presión prepara el despertar.
- La **privación crónica de sueño** se asocia con hipertensión, arritmias y mayor riesgo coronario.



5. Sistema inmunitario: la guardia nocturna

- Se **potencia la respuesta inmunitaria adaptativa**: proliferan linfocitos y se “ensayan” nuevas defensas.
- Dormir bien tras una **vacunación** mejora la producción de anticuerpos.
- En caso de infección, el cuerpo “pide” dormir más: la somnolencia forma parte de la respuesta inflamatoria.
- El sueño actúa como un turno nocturno de reparación inmunológica.

6. A nivel global: sincronía circadiana

El **reloj biológico** (núcleo supraquiasmático) coordina todos estos procesos con la luz y la oscuridad.

El sueño no es solo descanso: es mandar el sistema a la ITV, para un reseteo y actualización.

En resumen:

Durante el sueño el cuerpo:

- Limpia el cerebro.
- Repara tejidos.
- Consolida la memoria.
- Refuerza defensas.
- Ajusta hormonas y metabolismo.
- Sintetiza colesterol y reequilibra el metabolismo hepático.
- Protege el corazón.
- Y equilibra la mente y las emociones.



Tabla 1. Durante el sueño, hay un baile hormonal **finamente orquestado**:

Hormona	Durante el sueño	Función
GH	↑ en fases profundas	Reparación y crecimiento
Cortisol	↓ noche / ↑ madrugada	Despertar y alerta
Melatonina	↑ noche	Sincroniza ritmos circadianos
Leptina / Grelina	Ajuste energético	Control del apetito
Insulina	Sensibilidad ↑	Control glucémico
Colesterol hepático	Síntesis ↑ noche	Precursor de esteroides y membranas

Tabla 2. Balance general.

Sistema	Procesos clave durante el sueño	Resultado
Nervioso	Limpieza glinfática, memoria, emociones	Cerebro “reajustado”
Endocrino	GH ↑, melatonina ↑, cortisol ↓	Ritmo circadiano estable
Metabólico / hepático	Síntesis de colesterol, glucógeno, regulación insulina	Homeostasis energética
Cardiovascular	Descenso tensión y FC	Descanso miocárdico
Inmune	Activación linfocitaria	Defensa reforzada
Muscular	Reparación proteica	Recuperación física

Tabla 3. Horas de sueño recomendadas según la edad.

Etapas de la vida	Edad aproximada	Horas recomendadas por noche	Rango aceptable	Comentario clínico
Recién nacidos	0–3 meses	14–17 h	11–19 h	Sueño fragmentado, ciclos cortos; maduración del ritmo circadiano.
Lactantes	4–11 meses	12–15 h	10–18 h	Se consolidan las siestas; empieza la noche “larga”.
Niños pequeños	1–2 años	11–14 h	9–16 h	Siesta diurna importante para consolidar aprendizaje.
Preescolares	3–5 años	10–13 h	8–14 h	Transición hacia sueño nocturno único.
Escolares	6–13 años	9–11 h	7–12 h	El déficit de sueño afecta al rendimiento y conducta.
Adolescentes	14–17 años	8–10 h	7–11 h	Frecuente privación crónica por pantallas y horarios escolares.
Adultos jóvenes	18–25 años	7–9 h	6–11 h	Etapas de mayor flexibilidad, pero no inmunes a déficit.
Adultos	26–64 años	7–9 h	6–10 h	Menos sueño profundo, más fragmentación.
Mayores	≥ 65 años	7–8 h	5–9 h	Fases más cortas y despertares frecuentes, pero igual necesidad total.

Fuente: National Sleep Foundation, American Academy of Sleep Medicine y Sociedad Española de Sueño.

INSOMNIO: EL PAPEL ESENCIAL DEL FARMACÉUTICO COMUNITARIO

El insomnio es una de las consultas más habituales en la farmacia comunitaria y plantea un reto doble: detectarlo a tiempo y orientar bien al paciente, combinando consejo, prudencia y derivación cuando procede. Vamos a repasar su magnitud, causas, abordaje y el papel del farmacéutico en mejorar el descanso —y con él, la calidad de vida— de quienes lo sufren.

1. ¿Cuán frecuente es el insomnio?

El insomnio afecta en algún momento del año a un **40–43 % de los adultos españoles**, y el **insomnio crónico** alcanza al **10–14 %**. Su frecuencia aumenta con la edad y es más habitual en mujeres.

Estas cifras lo convierten en un auténtico **problema de salud pública**, con impacto físico, mental y social.

Dormir mal no mata, pero *desgasta sistemáticamente la salud*.

2. Tipos y causas: no todos los insomnios son iguales

Para poder orientar bien, conviene distinguir tanto la duración como la causa:

- Según la duración:**
- **Transitorio (días)** → estrés puntual, viajes, ruido, calor.
 - **Corta duración (menos de 3 semanas)** → cambios vitales, duelos, hospitalización.
 - **Crónico (más de 3 semanas)** → enfermedades físicas o psiquiátricas, fármacos, malos hábitos o sin causa aparente.

- Según la etiología:**
- **Primario (≈ 20 %):** sin patología de base clara.
 - **Secundario o comórbido (≈ 80 %):** asociado a ansiedad, depresión, enfermedades crónicas, consumo de fármacos, alcohol, cafeína o factores ambientales.

Entre los desencadenantes cotidianos destacan el **estrés, las preocupaciones laborales o familiares, los cambios de turno** y el uso abusivo de **pantallas por la noche**. En adolescentes, esto último es prácticamente epidemia.

3. Detección activa y cuándo derivar

El farmacéutico comunitario es, muchas veces, **el primer profesional sanitario al que el paciente comenta que “no duerme bien”**.

- Una conversación breve, pero dirigida, puede revelar mucho:
- ¿Desde cuándo duerme mal?
 - ¿Se despierta o le cuesta conciliar el sueño?
 - ¿Toma medicación, cafeína o alcohol con frecuencia?
 - ¿Cómo afecta a su día (somnolencia, irritabilidad, falta de concentración)?

Ante **insomnio crónico, severo o resistente a medidas iniciales**, o cuando hay sospecha de patología de base o uso continuado de hipnóticos, la derivación médica no es opcional: **es imprescindible**.

4. Consejo no farmacológico: la base del tratamiento

El **primer paso siempre es la higiene del sueño**, y aquí la educación sanitaria del farmacéutico marca la diferencia.

- Algunos recordatorios infalibles:
- Mantener horarios regulares, incluso fines de semana.
 - Evitar siestas largas y ejercicio intenso antes de acostarse.
 - Reducir cafeína, alcohol y comidas copiosas por la noche.
 - Crear un entorno oscuro, fresco, silencioso y cómodo.
 - Practicar técnicas de relajación o respiración.
 - Apagar pantallas al menos una hora antes de dormir.

Estas medidas parecen simples, pero aplicadas con constancia **resuelven una buena parte de los casos leves o transitorios**.

5. Productos disponibles en farmacia

Cuando las medidas no bastan o se trata de un insomnio leve o transitorio, el farmacéutico comunitario puede recomendar determinados productos, siempre tras una valoración individual.

Melatonina

- Regula el ritmo circadiano sueño-vigilia.
- Indicada en *jet lag*, trabajo nocturno o desajustes horarios.
- Actúa como **cronobiótico** (sin efecto hipnótico inmediato).
- No crea dependencia, aunque su efecto es gradual.
- Triptófano
- Precursor de serotonina y melatonina.
- Mejora el descanso de forma indirecta, especialmente en estrés o ánimo bajo.
- Seguro a corto-medio plazo, sin somnolencia residual.

Fitoterapia

- **Valeriana, pasiflora, melisa o amapola de California:** sedantes suaves que facilitan la relajación.
- La valeriana modula receptores GABA.
- Útiles en insomnio leve por nerviosismo o estrés.
- Precaución con la combinación con otros depresores del SNC.

Antihistamínicos sedantes

- **Doxilamina o difenhidramina**, de uso puntual.
- Mantienen la arquitectura del sueño, sin rebote, pero uso limitado.
- Siempre bajo consejo farmacéutico.

Y si con eso no basta hay que pasar por el médico para poder usar:

Benzodiacepinas e hipnóticos

- Muy empleados en España; actúan sobre receptores GABA.
- Riesgo de dependencia, tolerancia, somnolencia residual, deterioro cognitivo, caídas por alteración del equilibrio... sobre todo en mayores.
- Siempre dosis mínima eficaz y duración corta, bajo control médico.

Casualmente son los fármacos que nunca les sobran cuando vienen a retirarlos de la receta electrónica; pueden “quedar en casa” el del colesterol, el de la depresión, el de “la sangre”... pero el de dormir, no. Ese es el más necesario para el paciente. Y los analgésicos, claro.



Otro apunte sobre pacientes que usan las BZD: en todos los prospectos dice que deben de usarse “el menor tiempo posible” y lo cifran en “entre 8 y 12 semanas”. Ahora preguntar a la señora que tenéis al otro lado del mostrador cuantos años lleva usándolo. ¡Imposible retirarlo!

Más de las BZD: los efectos secundarios del uso a largo plazo pueden ir desde los citados antes a cosas más serias: noctambulismo y alucinaciones por Zolpidem, o parkinsonismo iatrogénico no reversible por Alprazolam (y Sulpirida, aunque no se emplee para el insomnio)

Última: los psiquiatras suelen decir que es insomnio si cuesta conciliar el sueño. Y prescriben hipnóticos: Lormetazepam y Zolpidem. Los demás que estamos dispensando —pensar en todas las demás benzodiacepinas— son ansiolíticos. Y si el paciente concilia el sueño, pero se despierta a las dos o tres horas, eso es síntoma de depresión. Que se trata con ansiolíticos hasta que el antidepresivo haga efecto; de ocho a doce semanas.

¿No os entran ganas de deprescribir benzodiacepinas?

Antagonistas duales de la orexina (DORA)

La gran novedad para **insomnio crónico**: fármacos como **daridorexant**, que bloquean los receptores OX1R y OX2R de la orexina, la sustancia que mantiene la vigilia.

Permiten conciliar y mantener un **sueño fisiológico**, respetando las fases profundas y REM.

El cuerpo mientras dormimos

Cerebro

- Limpieza glinfática: elimina desechos neuronales.
- Consolidación de memoria y aprendizaje.
- Regulación emocional.
- Sueño REM.

Músculos y tejidos

- Liberación de hormona del crecimiento (GH).
- Regeneración de tejidos y recuperación muscular.

Hígado y metabolismo

- Síntesis de colesterol y ácidos biliares.
- Reposición de glucógeno hepático.



Corazón y sistema vascular

- Disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
- Reducción del tono adrenérgico.
- Mantenimiento del ritmo circadiano cardiovascular.

Balance general

- Limpieza glinfática, memoria, emociones.
- GH ↑, melatonina ↑, cortisol ↓.
- Síntesis de colesterol, glucógeno, regulación insulina.
- Descenso tensión y FC.
- Activación linfocitaria.
- Reparación proteica.

No producen dependencia ni síndrome de abstinencia, y conservan la lucidez diurna.

El inconveniente: **precio elevado y necesidad de receta**, sin financiación.

Pero, cuanto más los conocemos, más prometedores resultan. Eso sí, el nombre parece elegido por un comité de insomnes con sentido del humor negro.

6. Interacciones relevantes

- **Melatonina:** riesgo bajo; posible potenciación de anticoagulantes o hipnóticos.
- **Fitoterapia:** puede potenciar sedantes, alcohol y benzodiacepinas.
- **Antihistamínicos:** suman somnolencia con otros depresores del SNC.
- **Benzodiacepinas:** cuidado con alcohol, opioides, antipsicóticos, antidepresivos y anestésicos —especial precaución en ancianos.

CONCLUSIÓN

El insomnio es un problema común, visible y tratable desde la farmacia comunitaria.

La detección precoz, los consejos de higiene del sueño y el conocimiento de los productos disponibles permiten al farmacéutico desempeñar un papel decisivo en el **descanso y bienestar de sus pacientes**.

Y cuando el problema se cronifica o escapa de nuestro alcance, la derivación médica oportuna es parte de la buena praxis.

Dormir bien no es un lujo. Es —como decíamos antes— **la ITV nocturna del cuerpo**, su momento de reseteo y actualización.

“El sueño no es un disparate, sino un texto que debe leerse en su propio idioma.”

— Sigmund Freud, 1900
(Que vaya negocio hizo con el sueño).



*EL SISTEMA GLINFÁTICO

Es uno de esos hallazgos que hace unos años *no existía en los libros de fisiología* y hoy nos obliga a replantear cómo entendemos el sueño y el cerebro.

Vamos por partes, con detalle científico pero claro.

El **sistema glinfático** (de *glía* + *linfático*) es un **mecanismo de drenaje cerebral** descubierto en 2012 por Maiken Nedergaard y su equipo en la Universidad de Rochester.

Durante mucho tiempo se pensaba que el cerebro *no tenía sistema linfático propio* (como el resto del cuerpo), pero se ha visto que **las células gliales** —en concreto, los astrocitos— cumplen esa función.

Es el “**servicio de limpieza nocturno**” del **cerebro**, encargado de eliminar los residuos metabólicos acumulados durante la vigilia.

¿Cómo funciona?

1. Durante el sueño profundo (fases N3), las **células cerebrales se contraen** un 60%. Esto **augmenta el espacio intercelular**, permitiendo que el **líquido cefalorraquídeo (LCR)** fluya con más facilidad entre las neuronas.
2. Ese flujo de LCR **entra por las arterias y sale por las venas**, arrastrando con él productos de desecho.
3. La **acuaporina-4 (AQP4)**, un canal de agua presente en las membranas de los astrocitos, es clave: actúa como “puerta hidráulica” que regula ese lavado.
4. El líquido “sucio” finalmente **drena hacia los senos venosos y los vasos linfáticos meníngeos**, descubiertos en 2015, y de ahí al sistema linfático cervical.

¿Qué elimina el sistema glinfático?

Principalmente:

- **β-amiloide** y **proteína tau fosforilada**, asociadas con **Alzheimer** y **otras demencias**.

- Metabolitos oxidativos y restos del metabolismo neuronal.
- Exceso de neurotransmisores o iones.
- Productos inflamatorios.

En vigilia, ese sistema funciona mucho peor.

Por eso, si dormimos poco, el cerebro **se “en-sucia” literalmente**, y eso se correlaciona con deterioro cognitivo, fatiga y envejecimiento neuronal acelerado.

¿Por qué solo durante el sueño?

Porque **solo al dormir**:

- se **reduce la noradrenalina**, lo que permite la expansión del espacio intercelular;
- el cerebro entra en **modo mantenimiento**, bajando su consumo energético;
- y las ondas lentas del sueño profundo actúan como un **bombeo rítmico** del LCR.

En estado de vigilia, la actividad neuronal impide esa expansión, así que el sistema glinfático queda en “modo pausa”.

Datos curiosos y clínicos

- En **privación crónica de sueño**, se acumulan proteínas neurotóxicas.
- En modelos animales, **un solo día sin dormir** aumenta los depósitos de β-amiloide.
- Se investiga su papel en **Parkinson, ELA, migraña** y traumatismos craneales.
- La **posición lateral (de lado)** durante el sueño favorece el drenaje glinfático.

En resumen

Fase	Qué ocurre	Consecuencia
Sueño profundo	Aumenta el flujo glinfático	Eliminación de toxinas y β-amiloide
Vigilia	Flujo reducido	Acumulación de desechos
Sueño insuficiente	Limpieza incompleta	Fatiga, deterioro cognitivo, riesgo neurodegenerativo

El sueño profundo es, realmente, la sesión de lavado del cerebro, no lo que hacen las sectas y los políticos.

acofarma
nesira

Aguas de Mar

Limpia e hidrata

Alivia la congestión nasal

Ayuda a aliviar los síntomas sinonasales

Adultos y niños



Higiene y cuidado nasal
100% natural

www.acofarma.com

Estos productos cumplen con la normativa sobre productos sanitarios. Precauciones: no usar en caso de hipersensibilidad al agua de mar. Es posible experimentar una ligera sensación de escozor temporal al iniciar su uso. Material exclusivo para el profesional sanitario.

Farmacia solidaria: compromiso profesional y acción social



En pasado mes de septiembre se presentó el III Barómetro Social de la Profesión Farmacéutica. El informe, elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), ofrece una radiografía exhaustiva sobre la contribución de la profesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y subraya, entre otros puntos, cómo a través de la colaboración con instituciones públicas y del tercer sector se están impulsando acciones que van mucho más allá de la labor asistencial tradicional.

El barómetro, basado en un análisis cualitativo y cuantitativo con la participación del 86,5% de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos españoles, analiza las iniciativas sociales, asistenciales y medioambientales promovidas desde la profesión, y refleja cómo los farmacéuticos están cada vez más implicados en propuestas de alto impacto social.

UN MAPA DE ACTUACIÓN QUE SE EXPANDE

Los datos confirman una tendencia al alza: de un total de **435 proyectos alineados con los ODS, 261 —el 60%— se pusieron en marcha en 2024.**

El barómetro divide las propuestas en cuatro grandes áreas. La más amplia es **Salud Comunitaria**, que agrupa el **46%** de las acciones. Su contenido refleja cómo los farmacéuticos están asumiendo funciones ligadas a la vigilancia epidemiológica, la educación sanitaria o el acompañamiento a colectivos vulnerables.

Las iniciativas incluyen programas de cribado de enfermedades transmisibles, detección precoz de patologías crónicas, campañas de promoción de hábitos saludables, prevención del tabaquismo y actuaciones vinculadas a salud mental o soledad no deseada. Destaca especialmente la creciente implicación en **violencia de género**, con **más de 14.000 farmacias acreditadas como Puntos Violeta**, que funcionan como espacios seguros donde las mujeres pueden recibir orientación y una derivación adecuada.

En **Atención Farmacéutica**, que representa un 25% de los proyectos, se incluyen la prestación de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA), programas de farmacovigilancia, campañas sanitarias o actividades formativas dirigidas a mejorar la práctica clínica del farmacéutico.

La **Acción Social** —18% de los proyectos— evidencia el papel del colectivo ante emergencias y situaciones de crisis, así como el apoyo a tareas de cooperación internacional o de recaudación de fondos y recursos, entre otras. La respuesta organizada ante la **DANA de Valencia** en octubre de 2024 es un ejemplo reciente: el Colegio de Valencia colaboró con Farmamundi y la Conselleria de Sanidad en la coordinación de la respuesta sanitaria para garantizar el acceso a medicamentos en las localidades afectadas.

En el área de **Acción Medioambiental**, con un 11%, se recogen servicios farmacéuticos como los SPD, la revisión de botiquines o la dispensación colaborativa. Entre las acciones más relevantes figura la colaboración con SIGRE, además de tareas de sostenibilidad en sedes colegiales y farmacias comunitarias.

ALINEACIÓN CON LOS ODS

El barómetro revela que el **ODS 3 (Salud y Bienestar)** vertebra la inmensa mayoría de los proyectos —el 98%—, algo coherente con el rol sanitario del farmacéutico.





La profesión farmacéutica está generando canales estables de cooperación, voluntariado y acción social, lo que amplifica el impacto de las ONG farmacéuticas y tradicionales y potencia la movilización del sector ante necesidades sociales

Otro elemento clave es la **colaboración**: el **95% de las iniciativas contribuye al ODS 17**, lo que evidencia que prácticamente en su totalidad se han creado junto a otros actores, principalmente instituciones públicas (31%) y entidades del Tercer Sector (26%). Además, los destinatarios han sido muy diversos: no sólo pacientes, sino poblaciones vulnerables como personas en riesgo de exclusión social (a las que se dirigen un 10% de las acciones), personas mayores, mujeres o jóvenes.

Por último, un porcentaje significativo se orienta al **ODS 10 (Reducción de las desigualdades)**, el **ODS 4 (Educación de calidad)** y el **ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles)**, mostrando que la farmacia se está consolidando como un agente activo en su compromiso con la sociedad.

MÁS ALLÁ DEL BARÓMETRO: COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR

Aunque el Barómetro no se centra específicamente en la colaboración entre las organizaciones del tercer sector y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF), esta se ha intensificado en los últimos años, principalmente con las que se encuadran dentro del ámbito farmacéutico, poniendo en marcha acciones orientadas a colectivos vulnerables, la salud comunitaria o la cooperación internacional.

Desde el **CGCOF**, por ejemplo, se impulsan unas convocatorias anuales de ayudas para proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Su objetivo es ofrecer apoyo económico a estrategias propuestas por

entidades del ámbito sanitario, preferentemente farmacéutico, que trabajen con las comunidades más vulnerables en países en vías de desarrollo.

Además, desde el año pasado cuenta con la plataforma online **FarmaColabora**, que facilita la visibilidad y difusión de acciones de organizaciones sin ánimo de lucro entre el colectivo farmacéutico.

Entre las entidades presentes destacan **Farmamundi**, **Fundación El Alto**, **Beyond Suncare**, **Banco Farmacéutico** o **Farma-solidaria**. Sus propuestas abarcan desde la mejora de los servicios de farmacias hospitalarias en África hasta programas de prevención del cáncer de piel en personas con albinismo, pasando por intervenciones contra la pobreza farmacéutica o acciones de apoyo psicosocial y sanitario a personas vulnerables en España.

Ambas herramientas han servido para canalizar fondos, voluntariado y recursos técnicos tanto en España como en el extranjero.

LA ACCIÓN COLEGIAL PROVINCIAL

A nivel provincial, los Colegios han ido consolidando modelos propios que conectan el ejercicio profesional con la acción social.

El **Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM)** ha desarrollado un modelo de voluntariado a través de la celebración de jornadas que generan puentes entre farmacéuticos y ONG, facilitando su participación en proyectos sociales y sani-



con la ONG **Más Que Farmacia**, creada por farmacéuticos, mediante el cual se desarrollan programas de atención social y seguimiento farmacoterapéutico para colectivos vulnerables, como mayores dependientes o personas sin hogar. Además, el acuerdo de colaboración con la **Fundación Banco de Alimentos de Sevilla** firmado en septiembre amplía este trabajo mediante campañas de sensibilización, voluntariado y captación de recursos.

El **Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba**, por su parte, firmó a principios de año un proyecto de colaboración con la **Compañía de las Hijas de la Caridad** centrado en la promoción de la salud en colectivos vulnerables, abordando temas como higiene, vacunación, nutrición o prevención de enfermedades.

Por su parte, el **COF de Cantabria** ha trabajado en programas de salud comunitaria que incluyen educación sanitaria y prevención del aislamiento social en zonas rurales, como parte de la iniciativa “Escuelas Rurales de Salud Mental”, y en **A Coruña**, el colegio ha participado en campañas de sensibilización y recaudación de fondos, por ejemplo, en la campaña navideña “Haz Magia con Guille” en 2023, destinada a apoyar a personas con enfermedades raras.

OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR

Además de los colegios y las ONG, también hay otras entidades del sector que actúan como agentes sociales.

Un ejemplo es la **Fundación Bidafarma**, creada por la cooperativa **Bidafarma** en 2022 con el objetivo de fomentar la formación y la investigación farmacéutica y promover la salud.

Entre sus iniciativas recientes destacan la **VIII Convocatoria de Proyectos de Innovación Social (2024–2025)**, que financia actividades de apoyo a infancia, personas con discapacidad, exclusión social o cooperación internacional; la campaña solidaria →

tarios. En 2023, más de un centenar de farmacéuticos participaron como voluntarios en acciones llevadas a cabo por ONG como **Banco de Alimentos de Madrid**, **Banco Farmacéutico**, **Cáritas Diocesana de Madrid**, **Cruz Roja**, **Farmamundi**, **Farmasolidaria**, **Farmacéuticos en Acción**, **Fundación A la Par** y **Manos Unidas**.

Paralelamente, el **COFM** mantiene un convenio de colaboración con **farmaSOLIDARIA**, orientado a promover acciones de proximidad desde la farmacia comunitaria que incidan en la salud, el bienestar y la integración de las personas más necesitadas.

Además, la dimensión internacional también está presente a través de la iniciativa **Infarma Solidario** impulsada conjuntamente junto al **Col·legi de Farmacèutics de Barcelona**, con la que se han financiado estrategias de cooperación farmacéutica en países con sistemas sanitarios frágiles. Entre ellos destaca el programa creado en Uganda, orientado a fortalecer los servicios de farmacia hospitalaria y a la capacitación técnica de estudiantes de farmacia en contextos sanitarios con recursos limitados.

Otros colegios han seguido líneas similares. En **Sevilla**, el **Colegio Oficial de Farmacéuticos** firmó el año pasado un convenio

“

La farmacia española constituye un agente importante en la implementación de los ODS vinculados a la salud, la equidad y las alianzas estratégicas.

junto a la asociación AOEx para niños con cáncer; la publicación de guías de prevención cardiovascular y de atención a personas con autismo en farmacias; así como los premios académicos en colaboración con la Academia Iberoamericana de Farmacia y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, destinados a impulsar la investigación y la formación en farmacia.

Otras cooperativas, como **Grupo Fedefarma**, también fomentan la responsabilidad social entre sus asociados en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. Durante el pasado año llevó a cabo diversas acciones como la campaña “Tú Latido Más Solidario” con Farmamundi, que consistió en la distribución de estuches con golosinas a farmacias para recaudar fondos; “La Nit”, de la Fundación Ared, financiando becas de formación en atención sociosanitaria; u ofreciendo dorsales a sus socios para participar en la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el objetivo de apoyar la investigación sobre esta enfermedad. Además, la cooperativa se implicó en El Gran Recapte, motivando a colaboradores y socios a donar alimentos a través de la Fundación Banc dels Aliments, y contribuyó a La Marató de TV3, destinada a la investigación de enfermedades respiratorias.

Por su parte, **Grupo Unnefar** también ha buscado fortalecer la dimensión asistencial y social de sus farmacias socias. Entre sus acciones más visibles se encuentra Cruzfarma Solidaria, lanzada hace unos años, en la que destinaba parte del importe de las bolsas de plástico a proyectos sociales y medioambientales. Más recientemente, en 2022, Unnefar convocó los Premios Ün-

nicos, dirigidos a reconocer iniciativas innovadoras, sostenibles o solidarias. Entre los galardonados se encontró la Farmacia González Artal en Zaragoza, que involucró a los vecinos de su barrio para ayudar a las personas sin recursos y que donó su premio a la ONG FarmaSolidaria.

Finalmente, cabe destacar a **LASEMI (Sociedad Española del Medicamento Individualizado)**, que ha creado la **Fundación LASEMI Cooperación** para llevar a cabo programas destinados a mejorar el acceso a medicamentos de calidad en poblaciones vulnerables. Entre sus iniciativas destacan la instalación de laboratorios de formulación magistral y la capacitación de personal local en países como Togo y Senegal, contribuyendo así al fortalecimiento de la atención farmacéutica en estos territorios.

UN MODELO CONSOLIDADO DE COMPROMISO PROFESIONAL

En definitiva, la profesión farmacéutica está generando canales estables de cooperación, voluntariado y acción social, lo que amplifica el impacto de las ONG farmacéuticas tradicionales y potencia la movilización del sector ante necesidades sociales. Además, permite que los farmacéuticos utilicen su formación de manera solidaria y profesional, aportando sus conocimientos técnicos, logísticos, de gestión de medicación y formación sanitaria. También evidencia que la farmacia española constituye un agente importante en la implementación de los ODS vinculados a la salud, la equidad y las alianzas estratégicas.



DESDE EL MOSTRADOR

Cuidado auditivo con Care+ Spray ótico

Care+ Spray ótico, de Stada, es una solución innovadora que suaviza y disuelve la acumulación de cerumen, facilitando su extracción y garantizando la limpieza del conducto auditivo externo.

Care+ Spray ótico proporciona:

- **Limpieza:** limpia y suaviza el conducto auditivo, promoviendo una buena higiene.
- **Facilitación de extracción:** suaviza el cerumen para permitir una extracción sencilla, evitando métodos perjudiciales como los bastoncillos.
- **Respeto por la microbiota:** mantiene un equilibrio saludable en el canal auditivo.
- **Cuidado delicado:** menos irritante que el peróxido de hidrógeno.

Este spray previene la formación de tapones de cerumen y es ideal para toda la familia, incluyendo niños mayores de 2 años, lo que le convierte en una alternativa segura para el cuidado auditivo. Su uso regular ayuda a mantener los oídos saludables y a disfrutar de una comodidad auditiva.



Señaliza los **precios** con **elegancia** en tu farmacia



acofar

- ✓ Uso fácil e intuitivo
- ✓ Resultados precisos en solo 5 segundos
- ✓ Muestra de sangre de 0,5 µL
- ✓ Almacena hasta 450 mediciones



Sistema de motorización de glucosa en sangre para pacientes con diabetes tipo II

Pack completo: 1 Glucómetro, 10 lancetas, 25 tiras reactivas, Dispositivo de punción, funda de tela y soporte de silicona.

www.acofarma.com

Estos productos cumplen con la normativa sobre productos sanitarios.
Material exclusivo para el profesional sanitario.